

采购需求、实施计划及审查意见

采 购 人：平潭综合实验区医院



项目名称：平潭综合实验区医院 2022 年-2024
年后勤服务采购项目

年 度：2022 年

第一部分 采购需求

一、采购项目实施的必要性：

本次招标为平潭综合实验区医院后勤服务管理（保洁、运送、工程、绿化养护）
招标，要求投标人根据招标文件要求，负责提供所需的相关服务。

二、开展需求调查

（一）根据《需求管理办法》第二十八条确定编制单位

编制单位：福建省智盛招标有限公司

编制时间：2022 年 11 月 16 日

（二）需求调查情况

1. 根据《需求管理办法》第十一条填写相应情形

☒应当开展调查

属于《需求管理办法》第十一条：（一）1000 万元以上的货物、服务采购项目，
3000 万元以上的工程项目

☐不重复开展调查

☐不需开展调查

2. 根据《需求管理办法》第十条填写需求调查事项相应情形

项目名称	平潭综合实验区医院 2022 年-2024 年后勤服务采购项目
调查人员	郭培红、林金雄、张玉兰、陈文钦、何新辉、福建省智盛招标有限公司
调查对象	本项目采用发布公告的形式开展论证，到公告截止时间止共有 8 家供应商提交了相关采购需求论证材料，具体名单如下：爱玛客服务产业（中国）有限公司、保利物业服务股份有限公司、碧桂园生活服务集团股份有限公司、福建省业泰科技有限公司、福建实达物业有限公司、福州中科美佳保洁服务有限公司、平潭中远商贸有限公司、江苏云帆保安服务有限公司
调查时间	2022 年 11 月 16 日

调查地点	福建省福州市鼓楼区古田路 121 号华福大厦四层 B 区福建省智盛招标有限公司
调查方式	论证

3. 需求调查结果

(1) 相关产业发展情况

共有 2 家公司提供了相关产业发展情况，产业发展情况良好。具体产业发展情况调查结果如下：

①爱玛客服务产业（中国）有限公司阐述如下：

医院后勤管理是现代医院管理中不可或缺的重要组成部分，是支撑和保障医院正常运行的重要基础。是保障医院医疗、教学、科研、预防、保健等工作正常进行的重要支柱。医院后勤服务涵盖多方面的专业知识，具有较强的技术性和专业性。

医院后勤服务主要职能包括：

- 1) 为医院提供环境和秩序管理服务，包括卫生保洁、绿化养护、秩序维护、停车场管理等；
- 2) 为医院提供其他辅助性服务，包括运送服务、导医服务、司梯服务、配餐服务等；
- 3) 为医院提供保障服务，包括保障设施设备运行与日常维护，以及水电煤正常供应等保障；
- 4) 组织对院内突发应急事件的处置等。

一、医院后勤保障发展历程

医院后勤保障系统随着现代医院管理模式而发展，从“传统封闭自我配套”的自支撑模式，逐步向“社会企业参与或承担”的开放模式转变，由粗放管理逐步向标准化、精益化、规范化、科学化、专业化管理转型。

1、后勤保障系统第一阶段：供给型与计划型管理

自解放后至 1965 年，我国最早的医院均实行福利性后勤保障形式，采取由单位基本包办生活后勤的低标准供给制，为员工与患者提供低廉的服务。

在 50 年代的供给制条件下，社会存在很大的供需矛盾，社会服务行业极其薄弱，无论硬件设施还是管理服务，都满足不了医院日益发展的后勤需要。于是，医院后勤保障以自办为主自成体系，形成了“小而全”的后勤配套服务体系，服务门类包括能源、交通、设备、房产、维修、绿化、伙食、通讯、家具、招待、托幼等等，其服务规模因医院大小有所不同，但大都独立于社会上同类服务行业，是按照行政事业单位的方式进行管理的。在当时的特定历史条件之下，医院的这种自办后勤模式存在其合理性与优势。

初期，后勤保障的管理职能与事务职能并未分离，管理人员均为经验丰富的基层技术工人。之后，为提高后勤工作的服务水平和管理能力，各医院逐步形成了较为系统的后勤事业行政型管理体制和后勤工作组织机构，并培养了一批后勤管理干部队伍，但从管理方式上来看，总体还是以粗放式经验管理为主。

2、后勤保障系统第二阶段:标准化与专业化管理

改革开放以后，随着旧经济体制逐步改革，福利性后勤服务的弊端也日渐暴露；我国社会、政治、经济格局发生重大转变，社会主义市场经济体制逐步形成，社会上第三产业普遍发展，供需矛盾逐步缓解，及医院服务水平和员工患者的需求不断提高，自办后勤体系已力不从心。在整个行政事业管理系统中，逐渐汲取了西方科学管理模式，医院管理、后勤保障管理也逐步从统计管理、目标管理向精益管理发展，管理人员从经验型向专业化转变，各个岗位均开始要求专业培训、专业资质、专业技术，各项工作都以制度化、规范化、标准化为方向推进。在这一阶段里，部分后勤保障服务单元实行“经济承包责任制”其典型案例是膳食服务的改革，把“统得过死、包得过多”的单纯行政管理及吃供给制大锅饭的管理体制，初步改变为行政管理与经营服务相结合的管理体制，实行管理费定额承包，改革分配制度，实行奖金分级；而部分单元则实行模拟企业化核算，其典型案例是单位的三产公司、自办产业承包部分经营性、服务性职能，建立和完善各种经营服务实体，同时也部分引进了市场竞争机制，优化了管理结构和程序，强化了检查、监控、调节、导向职能。

3、后勤保障系统第三阶段:精益化与社会化管理

党的十五大以后，我国社会主义市场经济体制的逐步完善，医疗保险制度、住房制度、社会保障等方面改革逐步完成，单位不再包办一切。社会服务行业的迅速发展和完善，为医院引进社会中的优质服务来替代已落后的小而全后勤成为可能。1994年，我国开始尝试探索医疗体制改革的方向；1998年，国务院颁布《关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》，医疗体制改革正式进入组织实施阶段。2000年2月，国务院体改办等八部委在《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》中明确提出了医院后勤管理社会化的概念；2001年7月，国务院在青岛召开的《全国城镇职工基本医疗保险制度和医药卫生体制改革工作会议》上再次提出：加快医疗机构后勤社会化改革。

二、医院后勤保障发展前景

1. 医院数量增加

随着中国健康产业固定资产投资的不断增加，中国医院总数于近年来稳定增长，由2016年的约29,000家增加至2021年的37,000家，复合年增长率为5.0%。医院数目不断增加刺激了对医院后勤服务的需求，因此，为中国医院后勤服务市场带来更广阔的发展前景。

2. 政府支持推动医院后勤外包

2002年12月，卫生部颁发了《关于医疗卫生机构后勤服务社会化改革的指导意见（试行）》，对医院后勤管理社会化改革相关问题做出了较为详尽的解释与回答。随着医疗机构管理机制的完善，后勤服务社会化的范围逐步扩大，从原有的保安、保洁等技术含量低、劳动力密集的项目进一步扩展至水、电、气等能源动力运行，网络信息系统管理，净化空调系统管理，餐饮管理等技术含量较高、对医院整体运行影响较大的项目。

2017年国务院办公厅在《关于建设现代医院管理制度的指导意见》中提出：“健全后勤管理制度。强化医院发展建设规划编制和项目前期论证，落实基本建设项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、工程监理制、质量责任终身制等。合理配置适宜医学装备，建立采购、使用、维护、保养、处置全生命周期管理制度。探索医院“后勤一站式”服务模式，推进医院后勤服务社会化”。中国政府建议推广医院后勤外包

并鼓励企业参与提供医院后勤服务。因此，政府的有关政策支持促进了中国医院后勤服务市场的发展。

3. 医院后勤服务要求不断提高

由于医院通常对环境安全、专业的设施管理及应对紧急事件及庞大且复杂患者人群的流入的强大能力具有较高的要求，医院后勤服务提供商一直持续改善彼等的服务质量并将服务范围自传统物业管理服务扩大至增值服务，如护理服务、医疗指导服务及医疗废弃物处理。医院后勤服务的要求不断提高，同时也推动了中国医院后勤服务市场服务标准的提高。

三、医院后勤保障发展趋势

近年来随着我国医疗卫生体制的不断改革，既往传统的管理模式已经无法满足当今医院飞速发展的需要，因此各医院都在探寻一条高效益、低成本，有效管理医院各层面的发展之路。后勤管理作为医院管理中重要组成部分，为医院各项工作的顺利进行提供了必要保障，所以优化后勤管理对提高医院整体服务水平以及发展具有重要意义。当前我国医院后勤服务都在向“精细化管理、后勤信息化管理、标准化管理”方向发展。

1、后勤精细化管理

1.1 精细化管理的内涵及运用于医院后勤管理中的意义

精细化管理概念起源于20世纪50年代的日本大规模工业化生产期间，60年代期间日本的丰田公司率先将精细化管理策略运用于实际管理过程中，取得了很好成果，并将其发展为一种完善的企业化管理模式。精细化管理是在常规管理的基础上进行更为详细的研究，主要目的在于通过利用较少的资源，实现有效降低管理成本、创造最大收益。总的来说，精细化管理就是在生产产品过程中，将各环节进行精细化分类探究，尽可能地优化生产流程和管理流程，使盈利得到最大化。精细化管理最为重要的一点在于不主张人治，而是推荐遵守既定制度和规范化的程序，需要管理者对被服务者充分了解，不断调整管理模式以适应被服务者的需求，成功完成角色转变。想要更好地实现精细化管理，必须掌握其含义，落实相关人员的培训，使精细化管理得到有

效发挥。精细化管理所涉及的范围极其广泛，对于组织管理的各个环节均可通过进行精细化管理，达到不断完善和提高各个环节运营效率的目标。精细化管理是一个不断要求提升的过程，需要相关人员具有自我管理及自我要求的积极性，才能实现目标，达成服务最优化。后勤管理是医院管理的重要组成部分，为医院各项工作顺利进行提供了一定保障，后勤管理通过将精细化的管理方针引入到实际工作中明显提高工作效率，为医疗工作者和病患提供了良好的环境和氛围，总而言之，实行精细化管理有利于医院各方面工作的开展，工作效率的提升并能促进医院的良好发展。

1.2 医院后勤管理现状以及引用精细化管理策略需注意的问题

现今医院后勤管理仍存在很多问题，致使工作效率低下，进而对于医院整体服务有所影响。主要是医院后勤管理制度不完善，在日常工作中未得到有效落实，致使岗位责任要求不明确，相关工作不能落实到个人，工作不到位。另外管理制度中经常存在一些口头制度，导致许多制度无法详细记录，也会导致与其他部门的衔接并不顺畅，最终使得医院各部门无法实现顺利协调，影响医院的整体水平。其次是医院的后勤工作人员个人素质有待提升，由于当今社会的不断进步和医疗水平的不断发展，对于医院后勤人员的要求也随之提高，更需要一批既具有扎实的医学专业知识又具备良好的管理水平的人才来负责医院后勤管理，然而由于当今医院过于重视医疗，而忽视了后勤管理，导致后勤管理缺乏专业人才，影响了管理工作的顺利进行。另外一方面是医院后勤管理工作人员的素质偏低，可能与其文化程度偏低有关，也可能与后勤管理工作的收入偏低，导致员工工作积极性较差，影响了后勤管理人员的整体素质。随着现代化进程的逐步推进，使得医疗系统蓬勃发展，越来越多的新型现代化仪器不断更新换代，这也增加了医院后勤管理工作的负担，然而由于医院忽略后勤管理，导致缺乏专业的仪器维修人员，使得医院的仪器故障得不到有效处理，影响了医院的整体水平带来不利影响。精细化管理理念在医院后勤管理中需要注意以下几个方面，①精细化管理方案难以贯彻落实。主要原因在于精细化管理需要注重细节，必须打破传统粗放式管理的束缚，但由于传统管理模式的根深蒂固导致新理念很难被接受和认真执行；并且因为后勤管理工作比较繁杂，工作完成的效率低及员工积极性不够，精细化管理

模式趋于形式化②精细化管理完成效率低，主要在于后勤管理人员的学历不够，管理水平一般。

1.3 精细化管理在医院后勤管理中的应用

为要使精细化管理策略在医院后勤管理中顺利执行并得到理想结果需要从以下几方面着手。

1.3.1 精细化管理制度

后勤管理人员需要在全院通过问卷调查形式收集各科室对后勤管理规章制度的建议，并结合自身特点进行综合分析，而后将详细工作细化到具体事务上，并渗透到各个环节中，做到每项工作均有据可循。还得通过与后勤员工签订任务书的形式深入明确具体工作，确保各项任务被认真执行，并定期抽查验收，制定奖惩制度，充分调动员工的工作积极性。

1.3.2 精细化后勤采购流程

为了更严格标准后勤的采购流程，可以将采购流程更为精细化，主要方法是：部门首先提出申请，后勤管理部门进行审核，经过院领导审核，组织召开表决会议，告知采购部门执行，并主动反馈进程，最后完成采购计划。在上述每一环节均需要有负责人按照精细化的规章制度认真执行，并将发现的问题及时上报。

1.3.3 精细化后勤成本核算

目前我国的医院成本费用明显高于西方国家，为了提高医院的收益，尤其在医院面临药品零加成和门诊药房托管的局面下需要我们必须精细化成本核算。将各部门申领的各类物资严格登记。同时出具合理使用各种医疗措施的规章制度，例如定期检查各部门的水、电、纸张及医疗器械的使用情况，督促其节约使用，避免浪费，并制定相应的奖罚措施。另外对于昂贵的大型仪器需要组织专业人员定期维护保养，尽最大可能延长设备的使用时间。

1.3.4 精细化后勤人员配置

医院应当给予后勤管理更高重视，帮助其组建一支高素质的管理团队，需要由认

真、严谨、求实、刻苦及具备创新精神的人才组成。另外医院也应当定期加强后勤人员的管理培训，并进行定期考核，保证管理工作的质量。此外，也应当提高后勤人员的薪酬待遇，可以通过设立奖惩制度的形式发放，并可将工作成果与职称评定等联系，提高人员的工作积极性，才可最大限度地创造个人价值，保障医院各项工作的顺利运转。

1.3.5 精细化与各部门的工作衔接

由于后勤管理工作覆盖范围广，经常需要处理许多工作衔接和人际关系，服务质量的好坏将直接影响医院的工作效率和整体形象，所以需要细化各项工作的衔接，以保障服务质量。这也需要后勤管理人员做到相互支持、相互依靠、上下衔接顺畅，还需不断处理突发情况及解决新问题，保障医院各项工作的顺利进行，提升医院的服务水平。

2、后勤信息化管理

当前，中国的医院建设迅猛发展，大量的健康需求，需要建设更全面的智慧医院来支撑。智慧医疗、智慧服务已经在医院落地应用，并取得了良好的效果。但在医院后勤的信息化管理上，多数医院重视程度不够，观念理念陈旧，管理方式传统。在信息化发展突飞猛进的 21 世纪，传统的医院后勤管理模式已经无法满足实际的工作需求。发展医院后勤信息化管理已成为了当前医院发展的基本要求。

医院后勤服务保障种类多，涉及面广，任务分散，监督管理难度大，无法精细化管理到每一个环节。从工作的制度化、格式化、程度化而言，采用传统的管理模式浪费资源、增大了管理成本。对于繁多的工作，往往采用粗放的管理方式，非常容易出现责任落实不清的情况，极易延误后勤服务效率，从而降低患者就医体验。后勤管理作为医疗服务和医院管理的重要环节，其信息化建设将影响到整个智慧医院体系的建设。

2.1 医院后勤信息化管理的内容及重要性

医院后勤信息化管理是一种新型后勤管理模式，具体来说就是对医院数据信息进行处理，归纳以及管理，因此，我们应该在确定工作方向时，有效的充分利用信息化

处理技术及手段来推进医院后勤信息化管理的可持续发展。充分利用智能的信息化工作管理方式有利于构建更科学更具体的绩效评价体系，及时掌握后勤各部门的信息。通过信息化管理对数据进行加工，从而使后勤工作更加规范有序。信息化管理技术的引入使医院管理资源得到了更有效的整合，同时可以实现远程交换管理资源。信息化管理同时可以迅速给医院管理层提供决策依据，从而提高医院管理决策的信息反馈效率。信息化管理模式有利于促进医院整体管理水平以及服务质量的提高，促进医院信息化建设的全面推进。

2.2 医院后勤信息化管理的现状

2.2.1 医院后勤缺乏重视信息化管理

医院管理层对医院后勤信息化管理不够重视，普遍认为医院的后勤工作局限于医院日常水、电、暖的维护，物资发放以及房地产的管理等。认为常规性管理关系不大，管理人员缺乏必要的信息管理技能，对信息化管理的重要性认识不足，但事实上若采用信息化手段可以使后勤管理工作更加简捷高效。

2.2.2 医院后勤管理模式较传统

现阶段，医院后勤管理工作人员局限于掌握基本的管理知识，停留在实际工作中主要有手工的单据记载即可的思想中。导致工作效率低，经济效益低。同时在长期的传统的后勤管理模式下，医院后勤部门灵活度较低，人员积极性及责任感较低，工作混乱，无法调动工作人员的积极性。甚至在失职时经常出现工作人员互相推脱责任的现象，极大程度上影响了医院的管理以及整体发展。因此，医院管理者首先应该改变传统的观念，采用信息化模式来管理及处理后勤工作。

2.2.3 医院后勤缺乏信息化管理人才

医院后勤信息化管理人才的缺失已经直接制约了信息化管理建设。因此，医院应当积极开展后勤管理工作并引进培养素质较高的信息化管理人才。后勤信息化管理人才不仅需要具备较高的信息技术能力，同时也应当了解信息学，管理学，人际交际学等，但当前绝大部分医院尚未开展后勤管理人员信息化管理的学习，人才配置整体信息技术水平较低，对信息化管理模式和信息化管理运作流程缺乏把握，从而大大地降低了医院后勤的工作效率及医院的经济效益。

2.2.4 医院后勤相关业务不够完善

医院后勤管理系统与医院各项业务紧密相连，所以既要保持一定的独立性，又要与其它已存在的医院信息系统（HIS）进行数据交换，这些运行在不同的网络硬件环境，采用的不同技术体系的系统由于来自不同的开发机构，所以可靠的医院后勤管理系统应具备支持主流的数据接口技术协议的数据接口能力。我们应该通过实践经验为医院后勤管理提供可靠的技术解决方案以及有效的管理信息采集处理流程设计。

2.3 医院后勤信息化管理的完善及发展

2.3.1 重视医院后勤管理中的信息化应用

信息技术是一种新型的管理技术，在医院后勤管理信息化建设中融入信息技术可以实现比较高效的医院现代化建设，但需要医院管理层具有客观理解对待信息化管理的意义和价值，提高对信息化建设的重视程度，在资金方面给予一定支持，为后勤信息化管理制定明确的管理目标，保证其建设目标与医院的综合战略方向相一致。然后将其作为医院的重要任务来管理，尤其是在当今医疗改革不断深入的背景下，医院后勤信息化建设更能突出其成本优势和价值优势。提高信息化管理的适用性，并以医院服务为核心，发展医院特色，为患者及医院提供更优质安全周到的后勤服务。当前医院后勤的信息化管理的首要任务就是改变陈旧的管理模式，不断创新完善当前信息技术下的管理流程，并对管理队伍进行优化整合，调动工作人员的积极性和责任感，将各项工作任务落实到每个人。在信息化管理体系的建设中，后勤岗位需要突出三维结构特点：服务对象、保障内容、经济特质。在管理内容上更要注重对患者和医疗服务的关联度，如与患者密切相关的治疗性物资保障如各种药物、消毒器械、实验标本等；与患者非医疗需求相关的如被服管理、食宿服务等；与临床支持相关的水电供应、环境卫生、废弃医疗物资回收处理等。

同时，医院管理层还需要客观认识后勤信息化管理建设与整个医院的管理战略有着密不可分的关系，领导层需要对此提起高度的重视，协调各部门相互配合并完成对接工作，以至于实现信息化管理的全面推进。将信息化建设与绩效考核相挂钩，以此调动工作人员的积极性和参与主动性，通过信息化管理为绩效考核提供更真实完整的数据依据，从而明确其考核指标，推进考核工作精准化、可量化发展。根据后勤信息

化管理需求制定与之相适应的制度规范，通过制度化管理规范信息化建设流程，保障其规范有序进行。

2.3.2 引进培养建设现代化管理人才队伍

一所医院的发展离不开全体医护人员的共同进步，信息化人才推动医院后勤管理的核心要素，因此加强各部门医疗工作人员的管理尤其重要。在建设中进一步突出信息化人才引进及培养的重要性，对当前后勤人员进行专业信息化技能培训，提高当前工作人员的信息素养，同时还要多方引入复合型人才，通过复合型优秀的人才带动后勤发展，并促进后勤信息化管理质量的提高。随时时代的变迁，后勤管理工作人员还应该做到随机应变，根据目标要求而改变自己工作的方式，确立每个后勤工作人员的工作任务，明确分工，确保每个工作人员明白自己的职责，以便于提高医院的管理水平。关于国家而言，也应该加强对于相关管理人才的培养，提高对后勤管理的重视程度。

2.3.3 健全完善后勤的管理机制

每一个稳定的部门都需要一个健全的管理机制，尤其是医院的后勤部门。引用信息化技术有助于提高医院的后勤管理水平，通过运用各种新型计算机管理软件，完善后勤管理机制，规划后勤工作的管理流程，以至于实现后勤部门的高效运转及后勤信息化管理工作更加简洁清晰明了。

2.3.4 建立全院监控报警体系

对关键设备和重要岗位情况进行监督监控。能够对设备运行情况、岗位运行现状进行实时监控，建立起网络化监控系统，同时对医院电力系统、水利系统、供暖及制冷系统进行实时监控，并将机房、锅炉房以及电梯运行等情况纳入报警体系内，做到综合管理、即时监控、重点防范、提前预警，从而有效应用医院后勤系统管理分散、人员配置不足等问题上，提高后勤管理能效。

2.3.5 建立全院就餐管理系统

在医院后勤信息化管理中，需要将患者就餐服务作为管理重点，为患者及家属提

供更多的便利服务。同时，还需要对患者和家属行为起到引导和监督作用，使其主动遵守医院各项规章制度，例如建立患者一卡通服务，实现从患者订餐、洗护服务管理、超市售卖、门禁管理等一条龙服务体系，将其融合到病员管理流程内，使患者获得更完善的医疗服务体验。

2.3.6 确立后勤工作模式的社会化进程

当今，随着医院管理模式的转变，后勤工作变得格外重要，因此，如何加快后勤工作变成了当下最需要解决的问题。对于医院后勤工作，首先需要确立一套标准的奖罚制度并严格按照该制度执行，并进行相应的奖罚。所有行为不规范，不负责，不上进的员工都应该给予处罚乃至处理。相应的，对于工作认真负责的后勤管理者，应该给予一定的鼓励支持，以至于保持其工作的热爱。后勤工作者热爱自己的工作，保证其工作的质量，并尽全力提高自己的工作效率，减少医院一切不必要的浪费。

3、后勤标准化管理

随着社会科学的不断进步与发展，医院后勤所涉及的专业领域越来越多，设施设备的技术含量越来越先进，其操控性和日常维修保养的难度也越来越大。以医院后勤设施设备为例，包括电力系统、锅炉系统、空调与通风系统、给排水系统、医用气体系统、电梯系统、照明系统等等。随着信息技术的高速发展，互联网和物联网技术的深入应用，这些医院后勤设施设备已经进入了智能化的阶段。传统的医院后勤管理技术含量不高、管理松散不规范、从业人员的素质相对偏低，已经不能满足现代医院后勤设施设备的维护与保障。

当前多数医院都将后勤服务从医院剥离出来，向市场开放，由第三方公司提供社会化服务。医院后勤服务外包主要有以下内容：保洁、运送、安保、餐饮、绿化、物业、维修、设备运行、专业检测等等。医院后勤服务社会化有利于医院人力、物力、财力资源的有效利用，降低成本，提高工作效率和医院后勤管理专业化水平。同时也带来了后勤外包服务管理难度大的问题：对承包的第三方进行有效地监督和管理，保质保量完成外包服务合同项目。

面对医院后勤管理所存在的众多问题，医院后勤管理标准化建设成为医院后勤管理发展的必然趋势，是保障医院正常运行的重要前提。随着医院对后勤保障要求的日

益提高，医院后勤管理从传统的经验性管理向专业化、精细化、标准化转型。

3.1 标准化

3.1.1 标准与标准化

在 2000 年发布的 GB/T1.1-2000 中将标准定义为：“为在一定的范围内获得最佳秩序，对活动或其结果规定共同的和重复使用的规则、导则或特性文件。该文件经协商一致制定并经一个公认机构的批准。（标准应以科学、技术和经验的综合成果为基础，以促进最佳社会效益为目的。”

标准化是为在一定的范围内获得最佳秩序，对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动。

3.1.2 标准化的目的与意义

从标准化的定义可以得知，标准化的目的就是通过制定规则来解决实际的或潜在的问题。因此，通过建立医院后勤标准化管理体系，可以解决医院后勤管理中现实所面临的或者将来有可能发生的问题。通过制定、执行一系列切实可行的医院后勤管理标准，进行纠正或预防，提高医院后勤综合保障能力。

3.1.3 医院后勤标准化管理体系的建设

建立医院后勤标准化管理体系，是医院后勤活动行为的准则和依据，使后勤工作规范化、流程化、制度化，以持续、高效、优化达到管理目标。医院后勤标准化管理体系建设需形成医院后勤标准化的规章制度、工作流程、岗位体系、服务模式等。同时，应采用 PDCA 循环、目标管理、持续改进等现代先进的管理方法和技术，以促进医院后勤标准化体系的建设与完善。

3.1.4 医院后勤标准化管理体系的 PDCA 建设模型

采用 PDCA 循环来建设医院后勤标准化管理体系，遵循科学程序，有序地保障医院后勤全面质量管理。

P (plan) 计划：通过健全医院后勤各部门、岗位、人员等组织管理和建立医院各项规章制度，有计划、有组织、有序地开展医院后勤活动。

D (do) 执行：严格按照标准化体系（规章制度、岗位操作流程、技术规范等），实施医院后勤业务操作。

C (check) 检查：按照工作质量标准，对各部门、岗位、人员的工作进行检查和

考核，发现实际或潜在的问题。

A (action) 处理：对检查的问题进行汇总分析，同时总结执行活动结果，总结经验，提出整改方法或措施，优化医院后勤管理标准体系。

基于 PDCA 循环，保障医院后勤标准化管理体系持续发展和提升，使医院后勤高效运营管理。

3.1.5 医院后勤标准化管理体系的目标管理

目标管理是以目标为导向，以人为中心，以成果为标准，而使组织和个人取得最佳业绩的现代管理方法。医院后勤标准化管理体系的目标管理，就是对医院后勤保障部门的每项具体工作和每个工作岗位都设定明确的工作目标，自上而下定期考评。后勤保障部门一般采取 360 度绩效考评法进行多维度采集评价，以此了解各方面对后勤保障工作的感受和反馈。

3.1.6 医院后勤标准化管理体系的持续改进

患者以及医疗工作者的需求是持续发展的，会随着科学技术的发展以及人民生活水平的发展而日益提高。医院后勤管理的水平也是日益发展完善和提高的。精益求精并持续改进是医院后勤管理标准化建设的主要内容也是其坚定的发展方向。持续改进是对已有工作的总结，发现实际或潜在的问题，通过制定整改方案或措施，保持医院后勤管理循环优化。持续改进是医院后勤管理连续改进某一或某些后勤工作过程以提高顾客满意度的方法。一般步骤包括确定改进目标、寻找可能的解决方法、测定实施结果、正式采用等。要求后勤部门全员参与、主动实施改进的氛围和环境，以确保改进过程的有效实施。

3.2 标准化建设与医院管理质量认证

后勤管理标准化建设是后勤部门积极参与医院质量管理认证的基础和保障。

3.2.1 国内医院管理质量认证

上世纪八十年代，在借鉴国际先进经验和做法的基础上，考虑我国实际，我国医院开始积极探索医院评审工作。1989 年 11 月卫生部印发《有关实施医院分级管理的通知》（卫医字(89)第 25 号）和《综合医院分级管理标准(试行草案)》，我国医院等级评审和分级管理工作正式启动，随着评审工作的不断深入，于 1995 年发布了《医疗机构评审办法》（卫医发〔1995〕第 30 号），初步规范了我国医院评审工作实施行

为。为全面推进深化医药卫生体制改革,提高医疗行业整体服务水平与服务能力,2008年以来,卫生部医疗服务监管司紧密结合公立医院改革工作重点,探索建立医院评审评价体系,在《医疗机构评审办法(1995年版)》的基础上,经过广泛调研、深入探讨,完成了《医院评审暂行办法》。我国医院评审评价标准(2017版)即将公布。新版医院评价标准通过多维度考察,以持续质量改进为指导思想,体现“以病人为中心”的整体理念。要持续开展医院评价与品质促进活动,提高中国医院科学化、规范化、标准化管理水平;制定科学的评价办法,强化培训指导,保证标准理解不偏离、标准执行不过度、标准落实日常化。

中国医院协会后勤管理专业委员会编制的《医院评价标准—后勤保障》,是目前试行的全国二级甲等以上综合性医院的后勤等级评价标准。

3.2.2 国际医院管理质量认证

国际医疗机构认证联(JCI)是目前世界卫生组织认可的全球评估医院质量的权威评审机构。JCI认证围绕医疗质量和病人安全,对医院后勤管理提出8项要求:医院消防安全、治安安全、有害物质管理、公共设施设备安全、医疗设备安全、物资供应管理、后勤外包服务安全、灾害应急准备。

3.2.3 医院后勤管理标准化与医院质量管理认证

医院后勤管理标准化是医院顺利通过国内外医院质量管理认证的基础与保障。医院认证不是目的,真正的目的在于通过认证的过程建设并完善医院全面质量管理体系,提高医疗水平和卫生服务水平。医院后勤管理标准化与医院质量管理认证互为基础又相互促进,相辅相成。

②碧桂园生活服务集团股份有限公司阐述如下:

医改大背景下,医院后勤服务社会化范围不断扩大,推动了医院物业管理的发展。头部企业占比不高,新选手进入医院物业市场有发展空间。专业的人做专业的事,医院物业因其领域特殊性,形成了市场进入的专业壁垒。品牌声誉难以在短期内打造,客户黏性高,医院一般不轻易替换服务供应商……这些是新进入医院物业服务市场的特点和难点。

医院物业的发展机遇：

后勤社会化仍在推进

医院后勤管理社会化改革为物业带来新机遇。2000年2月，国务院体改办等八部委在《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》中明确提出了医院后勤管理社会化的概念。我国医院后勤服务社会化改革自此开始启动。

随着医疗机构管理机制的完善，一方面，医院后勤服务社会化的范围逐步扩大，从原有的保安、保洁等技术含量低、劳动力密集的项目进一步扩展至水、电、气等能源动力运行，网络信息系统管理，净化空调系统管理，餐饮管理等技术含量较高、对医院整体运行影响较大的项目。对物业服务企业而言，医院物业服务从单一的保洁服务，扩展到秩序维护服务、设施设备运行服务、日常维修服务延伸至导医导诊服务、中央物流运送服务、生活护理服务等各种生活配套及便工服务等。

另一方面，医院后勤服务准入市场化，通过政府引导建立医院后勤管理市场准入制度，大力倡导医院后勤管理市场化，帮助医院把一部分后勤业务委托给服务好、质量优、信誉高、价格合理的物业服务公司，把医院后勤从单位后勤转变为社会后勤，促进医院后勤服务质量提升和成本下降。对物业服务企业而言，可通过政府招标网查看医院物业招标项目，凭借企业服务经营、服务品质等在竞争中取得项目管理权。

医院后勤服务社会化改革相关政策

发布时间	政策名称	相关部门	文件要点
2000.02	《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》	国务院体改办等八部委	明确提出医院后勤管理社会化
2000.12	《关于医疗卫生机构后勤服务社会化改革的指导意见（试行）》	国务院卫生部	为医院后勤服务社会化改革提供具体实施办法
2009.04	《国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》	国务院	深化医药卫生体制改革
2010.07	《关于公立医院改革试点的指导意见》	国务院	指导各地切实做好公立医院改革试点工作
2015.05	《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》	国务院	深化城市公立医院综合改革，进一步探索并尽快形成可复制可推广改革路径
2017.07	《关于建立现代医院管理制度的指导意见》	国务院办公厅	探索医院“后勤一站式”服务模式，推进医院后勤服务社会化
2020.07	《关于全面推进社区医院建设工作的通知》	卫生健康委	为进一步满足人民群众对基本医疗卫生服务需求，全面开展社区医院建设工作
2021.08	《关于深化公立医院薪酬制度改革的指导意见》	卫生健康委	允许医疗卫生机构突破现行事业单位工资调控水平，允许医疗服务收入扣除成本并按规定提取各项基金后主要用于人员奖励

资料来源：公开资料整理

医院物管的市场空间：

“十四五”末超七亿平米

十年来，我国不断通过新建、改建和扩建等方式增加医疗资源供给。根据全国年度统计公报数据，2012年全国医院数量为2.3万家，2021年达到3.7万家，十年医院数量的年复合增长率为5.34%。

近三年来增速有所放缓，复合增长率3.88%。医院数目不断增加带动了医院后勤服务需求增长，为医院后勤服务市场带来广阔发展空间。（医院数包含公立、私立医院，不含基层医疗卫生机构如乡镇卫生院、社区卫生服务中心等）。



数据来源：国家统计局，克而瑞物管整理

医院数量的快速增加，主要源于民营医院数量的增长。自统计局公报 2016 年公布了公立和民营医院数量以来，公立医院五年数量基本保持不变，而民营医院则自 2016 年的 1.6 万家增至 2021 年末的 2.5 万家，年复合增速 9.3%。民营医院数量的增长，给医院物业管理的市场化拓展带来更多机遇。



数据来源：国家统计局，克而瑞物管整理

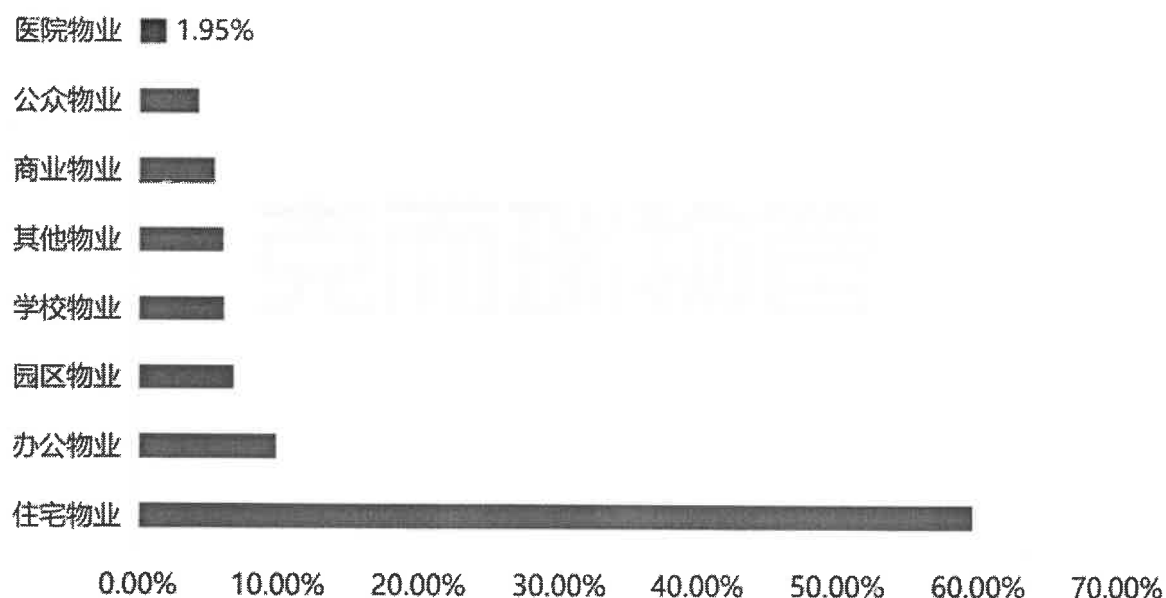
根据克而瑞物管 CPIC 数据库数据，物企综合实力 500 强管理的医院面积为 2.85 亿平方米，占 500 强管理总面积比例为 1.95%。据中国物业管理协会数据，2020 年末全国物业管理总面积约 330.4 亿平方米，按 500 强医院面积比例推算，全国医院物业管理面积约为 6.44 亿平方米。

克而瑞物管 CPIC 数据库预测，“十四五”末物业管理行业管理规模约达 387.87 亿平方米。按照目前 500 强物企 1.95% 的医院物业管理面积占比，预计到 2025 年末，医院物业管理总市场规模约为 7.56 亿平方米，比 2020 年底新增 1.11 亿 m²。

全国物业管理面积	500强医院管理面积比例	估算2020年底全国医院物业管理面积	预测2025年底全国医院物业管理面积
330.40亿m ²	1.95%	6.44亿平方米	7.56亿平方米

数据来源：克而瑞物管&中物研协整理

物企综合实力500强细分业态管理面积占比（2020）



数据来源：克而瑞物管&中物研协整理

另外，如果按照全国医院数量近三年增长率 3.88% 测算，预计 2025 年全国医院物业管理面积约为 7.79 亿平方米。

2020年底全国医院物业管理面积估算	年增长率假设	预测2025年底全国医院物业管理面积
6.44亿平方米	3.88%	7.79亿平方米

数据来源：克而瑞物管&中物研协整理

（2）市场供给情况

共有 2 家公司提供了市场供给情况，市场供给情况良好。具体市场供给情况调查结果如下：

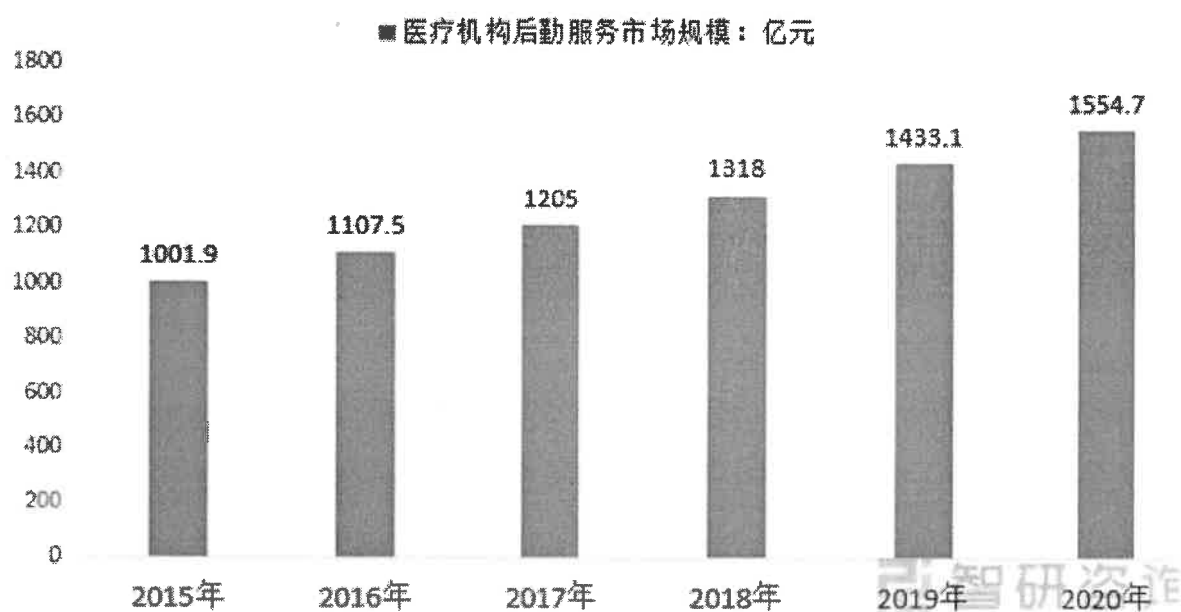
①爱玛客服务产业（中国）有限公司阐述如下：

国内医院后勤改革从上世纪末开始，首先以内部承包制为个案开始呈现出来，通过内部承包制，医院后勤管理整体服务水平和管理能力与改革之初相比都有所改善。进入 21 世纪后，我国医院后勤服务社会化改革正式启动。2000 年 2 月，国务院体改办等八部委在《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》中明确提出了医院后勤管理社会化的概念，2002 年 12 月，卫生部颁发了《关于医疗卫生机构后勤服务社会化改革的指导意见（试行）》，对医院后勤管理社会化改革相关问题做出了较为详尽的解释与回答。随着医疗机构管理机制的完善，后勤服务社会化的范围逐步扩大，从原有的保安、保洁等技术含量低、劳动力密集的项目进一步扩展至水、电、气等能源动力运行，网络信息系统管理，净化空调系统管理，餐饮管理等技术含量较高、对医院整体运行影响较大的项目。

智研咨询发布的数据显示：2020 年我国整体医疗机构后勤服务市场规模 1554.7 亿元，而这一数据在 2015 年仅为 1001.9 亿元，年均复合增速达 9.2%。

2015-2020 年中国医疗机构后勤服务市场规模情况

医疗机构后勤服务市场规模



医院后勤服务管理占医疗机构后勤服务市场的85%以上，尽管近年来其他医疗机构后勤服务市场规模有所上升，但所占市场份额仍较小。2020年我国医院后勤服务市场规模约1351亿元，同比2019年的1254亿元增长了7.74%。近几年我国医院后勤服务市场规模如下图所示：

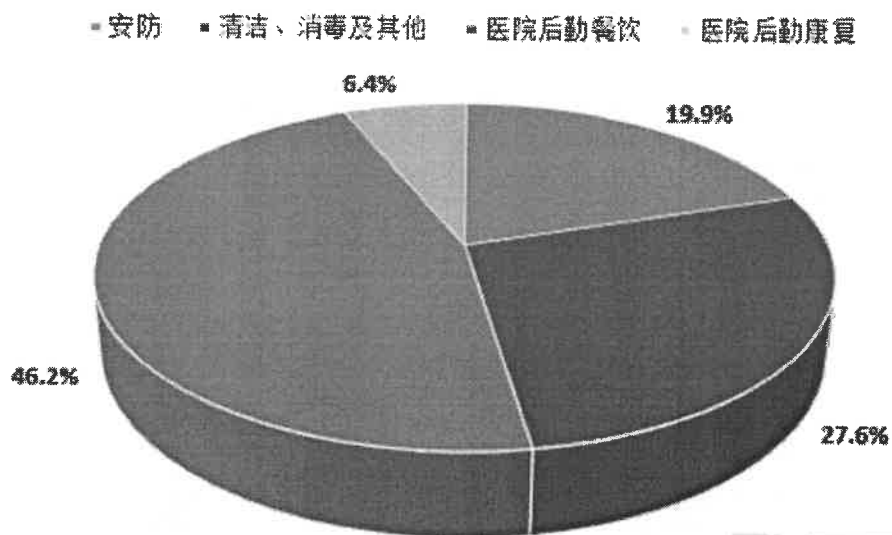
2015-2020年我国医院后勤服务市场规模情况



细分市场中以后勤餐饮服务为主，2020 年其市场规模占比为 46.2%；其次是清洁、消毒及其他服务，占比为 27.6%；安防和后勤康复分别占比 19.9%和 6.4%。

2020 年我国医院后勤服务细分市场规模情况

医院后勤服务市场细分结构



智研咨询

从行业供给来看，经过二十余年的发展，我国医院后勤服务行业头部企业开始崭露头角，少数企业已经成长为全国性、专业化、规范化的医院后勤服务企业。例如：爱玛客服务产业（中国）有限公司、上海益中亘泰物业管理有限公司、中航物业管理有限公司、深圳市明喆物业管理有限公司、上海吉晨卫生后勤服务管理有限公司、深圳市新东升物业管理有限公司等。

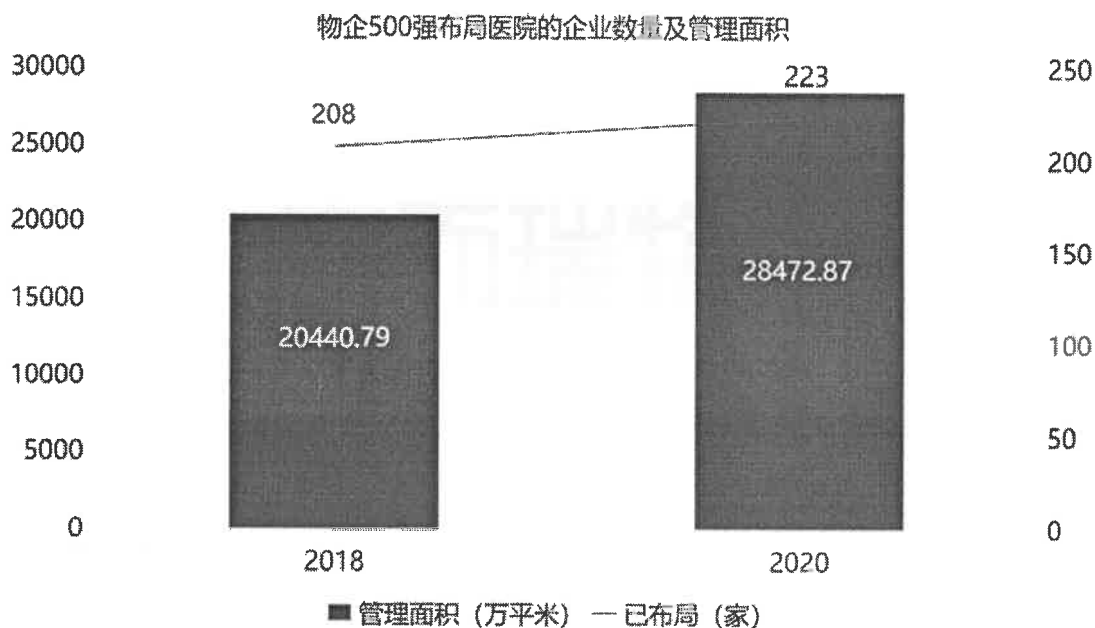
目前，医院后勤服务行业呈现“大小互争、群雄逐鹿”的竞争格局。但整体而言，由于医疗机构的地域分散性，后勤服务行业集中度仍较低。

近年来，我国医疗机构诊疗人次数量巨大且不断增加，同时医院和病床数量也有着巨大保有量和持续增长。我国医疗行业的庞大体量和增长速度，直接决定了医疗机构后勤服务市场的巨大规模和持续成长性。与此同时，我国民众对医疗服务的质量要求不断提高，在基本治疗需求得到满足后，对医疗服务所营造的就诊环境、服务态度和医院设施设备运行情况等的关注度逐渐上升，医院需要提供更好的后勤服务以满足患者需求。此外，随着信息技术等的发展，优秀的后勤服务提供商可在提供传统后勤

服务的同时，利用智能化、信息化手段提升医院后勤管理效率，医院后勤管理服务内容存在广阔的拓展空间。

②碧桂园生活服务集团股份有限公司阐述如下：

2018 年底至 2020 年底，综合实力 500 强物企中，布局医院的企业从 208 家增长至 223 家，数量略有提升。同时，500 强物企管理的医院面积从 2018 年的 2.04 亿平方米增至 2020 年的 2.85 亿平方米，年复合增长率为 18.2%。入局医院的企业数量增加不明显，但是管理面积增长显著。



数据来源：克而瑞物管CPIC数据库

园区物管市场主要参与方可分为两大类型：专业医院物管公司和大型综合性物企。

一、专业医院物管公司

现阶段从事医院物业服务的物企相对其他业态较少且多为中小企业，领域内较为知名的有国天物业、斯马特、明喆集团、医管家等。

一流的医院后勤服务供应商，其服务素质和运营管理实力，是通过长期运营而得到客户认可的，专业公司在医院后勤服务市场建立起稳定的客户群。医院也更倾向于

品牌知名度高的医院专业后勤服务供应商，新进入公司难以在短期内塑造品牌声誉，打造对抗一流医院后勤服务供应商的竞争力。

专业医院物管公司一览

企业简称	服务内容	服务规模	服务项目
医管家	上海益中巨泰（集团）股份有限公司（医管家）是国内市场化运作、跨区域经营、集团化管理的大型专业医疗机构后勤服务供应商，19年来专业从事医院环境管理、中央运送、工程管理、餐饮服务、秩序维护、电梯驾驶、绿化养护、导医服务、棉织品收发、停车管理、商业服务等后勤支持管理服务，是中国医院非临床服务的领跑者。	项目分布在全国80多个城市，服务面积超2700万平方米	上海交通大学医学院附属仁济医院、复旦大学附属中山医院、安徽医科大第一附属医院等180多个在管项目
斯玛特	斯玛特为客户提供服务包括：专业保洁、专业安保、设备运行与维护、消防中控管理、车场管理、专业电梯、会议接待、客户服务、园林绿化及养护以及其他项目服务在内的多元化、全方位的直接项目管理和运营。在医疗市场，还提供护工、病人及病历、标本的运送服务、洗衣及麻织品分发及配餐服务等。	项目分布在全国20个城市，服务面积1000万平方米	60多个服务项目覆盖北大系、清华系、中国医科大系、部队系等医院
国天物业	国天物业以医院物业服务为主业，服务内容包含卫生保洁（地面维护保养、生活垃圾收集运送、医疗垃圾收集运送、有害生物防制、消杀灭菌、绿化养护）；工程运维（变（配）电系统、中央空调系统、净化空调系统、医用气体制造、电梯维保、小型工程施工等）；医疗辅助（集中运送、陪检服务、患者陪护、导医导诊、患者营养配餐、洗衣房服务、术室专业服务）	服务面积近1500万平方米	北京同仁医院、北京小汤山定点医院、北京友谊医院、北京天坛医院、北京朝阳医院等
明喆物业	明喆拥有20年一体化医院物业服务经验，服务范围几乎囊括了相关机构和单位对一体化后勤服务的全部需求，其主要服务内容包括：保洁服务，绿化种植，安保服务，消防管理，后勤设施设备维护与保养，患者护理，导医导诊，会议服务，车辆管理，宿舍管理，商务服务等。	医院项目主要分布在全国34个城市，服务面积达930余万平方米	医院项目近百家，包含三甲医院、专科医院和传染病医院

数据来源：克而瑞物管&中物研协整理

1. 专业能力铸就品牌声誉

医院物业不仅注重加强专业服务能力建设，而且关注项目的个性化需求，并将服务范围扩大，如护理服务、医疗指导服务及医疗废弃物处理。如斯玛特物业，针对各个科室不同需求制定工作流程和工作标准，除基本的保洁和维修，每年免费为医院各科室进行地板清洗打蜡工作，配合院方完成食堂搬迁重建、办公楼搬迁重建等工作。

明喆物业，秉承“唯有专业，方得品味”的发展理念。在医疗废物处理方面，采用标准化制度和可视化流程，医疗垃圾与生活垃圾按照医疗废弃物管理标准进行分类储存，对垃圾站定期开展消毒作业，传染性污物按规定严格消毒，垃圾站垃圾每日清理，确保医疗垃圾安全投放等。

2. 医院物业智慧系统建设

2020年5月21日,《关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》出台,提出创新建设完善智慧医院系统,并且将电子病历、智慧服务、智慧管理三方面作为重点,加大医疗信息化建设的精力投入,加速医疗信息化的行业建设。其中智慧服务涉及医院后勤管理,成为医院物业服务企业的重要发展方向。

专业医院物管公司在智慧服务方面的具体措施

企业简称	智慧服务具体措施
国天物业	国天物业从服务的实践经验和客户服务需求中洞察到后勤管理模式转型的时机,坚持不懈地在“信息化管理、智慧化服务、高效化保障、专业化经营”上下真工夫,早在2016年便先后定制研发了“国天物业智慧管理平台”、“国天云”在线工单调度系统、“国天爱生活”等软件APP。国天云系统现在已拥有20大功能模块,逐渐实现医院后勤服务全覆盖
医管家	上海益中巨泰(“医管家”)专注医院后勤服务领域,以人性化和专业化为基础,以“创新智慧运营、赋能后勤服务力”为目标,建立医管家4.0医院智慧后勤解决方案与管理平台,实现赋能员工、赋能医院、赋能生态的服务理念
明喆物业	公司在医院项目上引进明智优点智慧物业管理平台,明智优点为明喆集团独立开发拥有自主知识产权的明智优点高端一体化后勤服务智慧平台,采用主流的微服务架构、大数据、AI人工智能等技术,紧紧围绕提升物业一线服务品质,全面支持微信小程序、APP、PC端等多渠道信息汇集

数据来源:克而瑞物管&中物研协整理

二、行业领先的大型综合性物企

近年来,除专业医院后勤服务物企,综合性服务企业也纷纷入局医院赛道。一部分物企通过收并购扩大细分规模,如远洋服务收购瓯睿物业、世茂服务收购梁士物业;一部分选择自主发力,例如新增经营范围、设立子公司,或者通过积极外拓来获取标的。

综合性物企拓展医院业态举措一览

企业简称	方式	举措
中海物业	市场化拓展/母公司交付等	· 2020年，在港澳地区成功投得多份医院管理局项目，为医管局辖下公立医院和医疗机构提供服务数目占全港医院总数三成以上。 · 2021年，持续拓展港澳地区政府项目。延伸至医院管理局辖下约50%的医院项目及香港医管局总部大楼。 · 2021年3月，中海集团旗下中国建筑国际承建的青衣方舱医院（首个竣工的中央援建香港方舱医院）正式交接。同日中海物业正式进驻协助香港政府医院提供清洁保安及后勤保障工作。2021年8月，为协和西单院区门诊楼提供服务。9月北京协和医院转化医学综合楼正式启用。为物业服务方。
招商积余	市场化拓展	· 2017年起，招商积余旗下中航物业陆续发布了等数十项医院业态企业标准，形成具有医院业态特色的标准化服务体系。 · 2020年底，医院在管项目超过15个，包括广东省人民医院、广州医科大附属第三医院、广州医学院荔湾医院、成都双流区第一人民医院、深圳大学总医院、深圳市龙岗区人民医院、山东省皮肤病医院、汉中3201医院等知名大型医院，医院业态服务已颇具规模。 · 2021年，持续巩固非住市场领先优势，非住单体面积大业态有所突破，医院类如四川大学华西天府医院。
碧桂园服务	市场化拓展	· 碧桂园服务在2021年成立了城市服务集团，重点聚焦于市政、空间运营、产业园区、校园、医院五大核心赛道。建设城市服务生态圈，市政服务659个项目，空间、老旧小区运营6个，机场16个，轨交14个，产业园区80多个，文旅景区11个，校园47个，医院后勤21个。
龙湖智慧服务	市场化拓展/投资合作	· 2018年，接管重庆两江新区的“佑佑宝贝妇儿医院”。 · 2019年与浙江非核心医疗综合服务企业康禧集团达成战略合作，欲深耕医疗后勤服务领域。康禧旗下浙江康禧物业是浙江省最大的医院后勤综合服务提供商，具有丰富的三甲复评和JCI评审经验，为浙江超过50家医院提供医疗后勤服务。
新城悦服务	收购	· “大社区+大后勤”战略。2021年收购了6家物业服务公司，其中梁士物业、霸洁物业聚焦医院业态。 · 2021年6月，通过收购梁士物业，新城悦服务首次进入到医院物业管理领域。（梁士物业是中国最早的一批专业从事医院后勤服务的企业之一。管理区域遍布宁波、嘉兴、绍兴、金华、温州、丽水、南京。） · 2021年9月，与贵州霸洁物业股权战略合作。霸洁物业成立于2010年，医疗类业态项目涉及导医导诊、中央运输、专项护理等专业后勤管理服务。
雅生活服务	收购	· 2021年7月收购济南宏泰合共100%份额，总对价为人民币2.82亿元。山东宏泰在山东地区及华北地区具有较高市场份额，尤其在公共建筑市场细分领域极具品牌影响力，在管项目主要包括学校、政府机构、市政场馆、医院等多种非住宅业态。
世茂服务	收购	· 2021年12月，世茂服务与湖南吉立物业达成股权合作，以9964万元受让其70%股权，拓展医院细分赛道，深耕湖南物业市场。
远洋服务	收购	· 2017年开始布局医疗业态物业服务。收购山东联泰物业，专注于医院、学校、写字楼、办公楼、政府机关等企事业单位后勤保障和公共设施管理的专业公司。提供医院保洁、运送及设施管理服务。 · 2021年收购颐睿物业。颐睿物业成立于2004年，深耕温州，聚焦于医疗业态，除传统的医院保洁、工程管理、秩序维护等基础服务，还为大型综合医院提供中央运送、辅医服务、陪护服务等。

数据来源：克而瑞物管&中物研协整理

在医院领域已经具备管理基础的综合性物企，如中海物业、招商积余等，积极通过市场化招投标等方式拓展医院市场。

中海物业利用在港澳地区优势，持续拓展港澳政府医院项目。加上中海集团建设交付，进一步巩固优势。在内地协和医院项目，从为医院学术会堂提供服务，到为西单院区门诊楼提供服务，2021年9月为新完工的北京协和医院转化医学综合楼提供物

业服务，通过服务百年协和树立标杆，塑造医院管理品牌声誉。招商积余携公建物业的服务优势和基础，开始更加关注拓展单体项目的规模和体量。

收并购方面，以新城悦服务、世茂服务为代表，通过收购地方专业医院物管公司，拓展医院赛道。

新城悦服务在 2021 年 6 月通过收购梁士物业，首次进入到医院物业管理领域。梁士物业是中国最早一批专业从事医院后勤服务的企业之一，管理区域主要分布于宁波、嘉兴、绍兴等地；收购霸洁物业进入贵州医院物管市场。世茂服务收购湖南吉立物业进入湖南医院物业市场。雅生活收购山东宏泰进入山东包括医院在内的公建物业市场。远洋服务收购瓯睿物业进入浙江温州市场。收并购案例中可见，出售企业多为地方性医院专业物企，综合物企通过收购，一是首先快速切入医院领域，二是从区域性市场入手、着眼全国布局。

(3) 同类采购项目历史成交信息

①爱玛客服务产业（中国）有限公司部分历史成交信息：

序号	项目名称	业主名称	服务项目	服务期限
1	福建省妇幼保健院后勤服务采购项目	福建省妇幼保健院	保洁、运送、工程、导诊	2020. 8. 1~ 2023. 7. 31
2	海南省人民医院 2021 年医院“大后勤”社会化管理服务项目	海南省人民医院	环境保洁、绿化、中央运送（含助理护士、陪检、导医导诊、电瓶车便民服务）、设施设备运行与维护（工程）、秩序维护（保安）、消防安全管理及设施维护、洗涤洗衣；停车场收费管理、陪护（含陪人床）及餐厅服务管理	2021. 8. 9~ 2024. 8. 8
3	萍乡市人民医院物业管理服务项目	萍乡市人民医院	环境保洁、运送服务、保安服务、电梯驾驶服务、设备运行与维护服务	2022. 2. 1~ 2024. 1. 31

序号	项目名称	业主名称	服务项目	服务期限
1	福建省妇幼保健院后勤服务采购项目	福建省妇幼保健院	保洁、运送、工程、导诊	2020.8.1~ 2023.7.31
4	江西省人民医院物业管理服务项目	江西省人民医院	环境保洁服务、中央运送服务、设备运行与维护服务	2021.3.1~ 2024.2.28
5	南京市第一医院物业服务	南京市第一医院	环境保洁、中央运送（含调度中心）、送餐服务、司梯服务、安保服务、设备运行管理	2019.1.1~ 2023.12.31
	...			

②碧桂园生活服务集团股份有限公司历史成交信息：

序号	合同名称	合同开始时间
1	天津市第四中心医院	2021-01-29
2	宿州第二人民医院	2022-04-01
3	普宁华侨医院	2022-03-01
4	南京国悦医院有限公司	2022-03-14
5	南京葛塘悦城医院有限公司	2022-03-14
6	南京怡悦医院有限公司	2022-03-14
7	南京玄武好悦医院有限公司	2022-03-14
8	南京荟宁医院有限公司	2022-03-14
9	南京江宁悦成中医医院有限公司	2022-03-14
10	南京玄武好悦养老服务有限公司	2022-03-14
11	东部战区海军医院（保洁保安服务）	2021-03-01
12	广州安和泰妇产医院	2021-05-20
13	广州安和泰妇女婴护理服务后勤物业	2021-05-20

序号	合同名称	合同开始时间
14	佛岗县中医院	2022-01-01
15	东部战区空军医院保障社会化项目	2021-05-01
16	武警湖北总队医院	2022-01-01
17	商丘利君医院	2020-04-01
18	北京大学人民医院白塔寺院区、西直门院区探视管理	2022-01-01
19	沈阳市第五人民医院	2021-08-01
20	北京市疾病预防控制中心	2021-01-06
21	滁州市中西医结合医院医技内科住院大楼	2020-12-15
22	德兴市人民医院	2016-12-20
23	佛山爱尔眼科医院	2021-05-01
24	香港柏龄-紫云间隽逸护养院暨长者日间护理单位	2021-07-01
25	遵义市中心血站（遵义市疾病预防控制中心）	2020-08-01
26	安贞医院	2021-09-20
27	德阳市第二人民医院	2020-11-01
28	美兰湖妇产科医院	2019-06-01
29	宁夏工人疗养院（新园区）短期安保服务	2021-09-01
30	苏州相城区第三人民医院	2021-02-01
31	苏州相城区第三人民医院（金额增加）	2021-11-01
32	长白医院	2021-01-01
33	西南医投集团（泸州体检中心	2021-01-01
34	四川省人民医院西区	2021-06-28
35	长沙捷奥肾病医院	2021-07-1

（4）可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

本项目为服务类项目，未涉及运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况。

（5）其他相关情况

专家意见如下：

①江苏云帆保安服务有限公司未提供相关产业发展情况、市场供给情况、同类采购项目历史成交信息、其他相关情况等材料，不予论证。该公司建议的 F3.3 企业强化培训管理情况修改意见具有倾向性，不符合政府采购相关政策、法律法规要求。

②福建省业泰科技有限公司未提供相关产业发展情况、市场供给情况、同类采购项目历史成交信息，不予论证，该公司建议的 F3.3 企业强化培训管理情况、F3.4 企业业绩、F3.5 企业在管项目、F3.6 企业满意度修改意见具有倾向性，不符合政府采购相关政策、法律法规要求。

③福州中科美佳保洁服务有限公司未提供相关产业发展情况、市场供给情况、同类采购项目历史成交信息，不予论证，该公司建议的 F3.3 企业强化培训管理情况、F3.4 企业业绩、F3.5 企业在管项目、F3.6 企业满意度修改意见具有倾向性，不符合政府采购相关政策、法律法规要求，不予采纳。

④平潭中远商贸有限公司未提供相关产业发展情况、市场供给情况、同类采购项目历史成交信息，不予论证。该公司质疑的 F2.3 项目经理的修改意见不完整，不符合政府采购相关政策、法律法规要求，不予采纳。该公司质疑的 F3.1 企业综合实力、F3.2 企业专业认证、F3.3 企业强化培训管理情况、F3.4 企业业绩、F3.5 企业在管项目、F3.6 企业满意度的修改意见，不符合政府采购相关政策、法律法规要求，不予采纳。

⑤福建实达物业有限公司未提供相关产业发展情况、市场供给情况、同类采购项目历史成交信息、其他相关情况等材料，不予论证。

⑥相关产业发展情况、市场供给情况、同类采购项目历史成交信息建议参考爱玛客服务产业（中国）有限公司、碧桂园生活服务集团股份有限公司。

⑦保利物业服务股份有限公司未提供符合本项目的相关产业发展情况、市场供给情况、同类采购项目历史成交信息、其他相关情况等材料，不予论证。

⑧福建实达物业有限公司未提供符合本项目的相关产业发展情况、市场供给情况、同类采购项目历史成交信息、其他相关情况等材料，不予论证。

⑨建议将评分标准中“F2.3 项目经理”中的“①具有全日制本科（含）及以上学历（须提供有效学历证书复印件）”修改为：“①具有本科（含）及以上学历（须提供

有效学历证书复印件)”。

⑩建议将评分标准中“F2.3 项目经理”中的“④提供以往作为项目经理（管理负责人）代表投标人服务过的医院出具的相关工作经验证明材料复印件”修改为：“④提供以往至少一年及以上作为项目经理（管理负责人）服务过的医院出具的相关工作经验证明材料复印件”。

⑪建议将评分标准中“F2.4 设备设施配置的情况”中的“必须提供设备的产地、名称、件数等文件”修改为：“必须提供设备的技术参数、名称、件数等文件”。

⑫建议将评分标准中涉及“方案生搬硬套存在明显缺漏、不可行的或未提供的本项不得分。”的修改为：“方案存在明显缺项、不可行的或未提供的本项不得分。”。

⑬本项目采购需求合理、客观、完整，无倾向性、排他性、歧视性条款，满足招标所需的基本条件，符合政府采购相关政策规定。

（三）需求清单

1. 根据《需求管理办法》第七条填写项目概况

（1）本次招标为平潭综合实验区医院后勤服务管理（保洁、运送、工程、绿化养护）招标，要求投标人根据招标文件要求，负责提供所需的相关服务。

（2）投标人应以包括完成本项目所涉及的有关项目的费用进行报价，包括但不限于：基础设施和设备配备、项目宣传、项目运营人员（人员工资、福利待遇、劳保培训、项目管理等费用）、项目运营车辆、项目智慧监管平台、税收等一切相关费用。

（3）投标人的投标报价超过最高限价的投标无效，中标后不得转包、分包、挂靠。

（4）投标人务必仔细阅读招标文件中所规定的，其中包括技术规格在内的所有细则。

2. 采购项目预算

项目预算：23930000 元

包 1 预算：23930000 元

3. 根据《需求管理办法》第六条、第八条、第九条设置技术要求和商务要求

包号	技术商务要求	具体内容
包 1	技术要求	本次招标服务范围含平潭综合实验区医院新院区及老院区。 1、新院区门诊楼； 2、新院区病房楼； 3、新院区影像楼； 4、新院区台胞中心； 5、新院区感染楼； 6、新院区动力楼； 7、新老院区绿化养护； 8、老院区住院部； 9、老院区门诊医技大楼； 10、新老院区附属区域； ★11、项目标准工时人数不得低于 246.65 人（两院合计人数）。 详见第一部分 采购需求《附件》。
	商务要求	1、交付地点：福建省福州市平潭县北厝镇临湖七路 2 号、潭城镇东大街 15 号。 2、交付时间：★中标后 15 日内需进驻采购人指定地点开展服务。 3、交付条件：本项目经采购人验收，达到验收合格标准。 4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：5%。说明：中标人在签订政府采购合同前三日内应向采购人缴纳合同总金额 5%的履约保证金，履约保证金在本项目服务期满并验收合格后自动无息退还。

5、是否邀请投标人参与验收：否		
6、验收方式数据表格		
验收期次	验收期次说明	
1	具体详见采购文件考核内容要求	
7、支付方式数据表格		
支付期次	支付比例 (%)	支付期次说明
1	4.16	按月支付服务费。中标人在每月十日前将甲乙双方确认后的金额的上月发票（新老院区的实际金额发票须分开提交）交付采购人，采购人在收到中标人的发票后 20 个工作日内付款。
2	4.16	按月支付服务费。中标人在每月十日前将甲乙双方确认后的金额的上月发票（新老院区的实际金额发票须分开提交）交付采购人，采购人在收到中标人的发票后 20 个工作日内付款。
3	4.16	按月支付服务费。中标人在每月十日前将甲乙双方确认后的金额的上月发票（新老院区的实际金额发票须分开提交）交付采购人，采购人在收到中标人的发票后 20 个工作日内付款。
4	4.16	按月支付服务费。中标人在每月十日前将甲乙双方确认后的金额

				的上月发票（新老院区的实际金额发票须分开提交）交付采购人，采购人在收到中标人的发票后 20 个工作日内付款。
		5	4.16	按月支付服务费。中标人在每月十日前将甲乙双方确认后的金额的上月发票（新老院区的实际金额发票须分开提交）交付采购人，采购人在收到中标人的发票后 20 个工作日内付款。
		6	4.16	按月支付服务费。中标人在每月十日前将甲乙双方确认后的金额的上月发票（新老院区的实际金额发票须分开提交）交付采购人，采购人在收到中标人的发票后 20 个工作日内付款。
		7	4.16	按月支付服务费。中标人在每月十日前将甲乙双方确认后的金额的上月发票（新老院区的实际金额发票须分开提交）交付采购人，采购人在收到中标人的发票后 20 个工作日内付款。
		8	4.16	按月支付服务费。中标人在每月十日前将甲乙双方确认后的金额的上月发票（新老院区的实际金额发票须分开提交）交付采购人，采购人在收到中标人的发票后 20

			个工作日内付款。
9	4.16		按月支付服务费。中标人在每月十日前将甲乙双方确认后的金额的上月发票（新老院区的实际金额发票须分开提交）交付采购人，采购人在收到中标人的发票后 20 个工作日内付款。
10	4.16		按月支付服务费。中标人在每月十日前将甲乙双方确认后的金额的上月发票（新老院区的实际金额发票须分开提交）交付采购人，采购人在收到中标人的发票后 20 个工作日内付款。
11	4.16		按月支付服务费。中标人在每月十日前将甲乙双方确认后的金额的上月发票（新老院区的实际金额发票须分开提交）交付采购人，采购人在收到中标人的发票后 20 个工作日内付款。
12	4.16		按月支付服务费。中标人在每月十日前将甲乙双方确认后的金额的上月发票（新老院区的实际金额发票须分开提交）交付采购人，采购人在收到中标人的发票后 20 个工作日内付款。
13	4.16		按月支付服务费。中标人在每月十日前将甲乙双方确认后的金额

				的上月发票（新老院区的实际金额发票须分开提交）交付采购人，采购人在收到中标人的发票后 20 个工作日内付款。
		14	4.16	按月支付服务费。中标人在每月十日前将甲乙双方确认后的金额的上月发票（新老院区的实际金额发票须分开提交）交付采购人，采购人在收到中标人的发票后 20 个工作日内付款。
		15	4.16	按月支付服务费。中标人在每月十日前将甲乙双方确认后的金额的上月发票（新老院区的实际金额发票须分开提交）交付采购人，采购人在收到中标人的发票后 20 个工作日内付款。
		16	4.16	按月支付服务费。中标人在每月十日前将甲乙双方确认后的金额的上月发票（新老院区的实际金额发票须分开提交）交付采购人，采购人在收到中标人的发票后 20 个工作日内付款。
		17	4.16	按月支付服务费。中标人在每月十日前将甲乙双方确认后的金额的上月发票（新老院区的实际金额发票须分开提交）交付采购人，采购人在收到中标人的发票后 20

			个工作日内付款。
18	4.16		按月支付服务费。中标人在每月十日前将甲乙双方确认后的金额的上月发票（新老院区的实际金额发票须分开提交）交付采购人，采购人在收到中标人的发票后 20 个工作日内付款。
19	4.16		按月支付服务费。中标人在每月十日前将甲乙双方确认后的金额的上月发票（新老院区的实际金额发票须分开提交）交付采购人，采购人在收到中标人的发票后 20 个工作日内付款。
20	4.16		按月支付服务费。中标人在每月十日前将甲乙双方确认后的金额的上月发票（新老院区的实际金额发票须分开提交）交付采购人，采购人在收到中标人的发票后 20 个工作日内付款。
21	4.16		按月支付服务费。中标人在每月十日前将甲乙双方确认后的金额的上月发票（新老院区的实际金额发票须分开提交）交付采购人，采购人在收到中标人的发票后 20 个工作日内付款。
22	4.16		按月支付服务费。中标人在每月十日前将甲乙双方确认后的金额

				的上月发票（新老院区的实际金额发票须分开提交）交付采购人，采购人在收到中标人的发票后 20 个工作日内付款。
		23	4. 16	按月支付服务费。中标人在每月十日前将甲乙双方确认后的金额的上月发票（新老院区的实际金额发票须分开提交）交付采购人，采购人在收到中标人的发票后 20 个工作日内付款。
		24	4. 32	按月支付服务费。中标人在每月十日前将甲乙双方确认后的金额的上月发票（新老院区的实际金额发票须分开提交）交付采购人，采购人在收到中标人的发票后 20 个工作日内付款。
		★8、违约责任：		
		（1）投标供应商中标后，如果有以下情形的，均视为中标人违约，采购人有权不予签订合同，如果已经签订合同的则合同自动解除，并报政府采购监管部门予以处置。且中标人还要承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，还需另行支付相应的赔偿。 1) 投标供应商中标后，除不可抗力外，如果因中标供应 商原因不按规定无法按时与采购人签订服务合同的，没收投标人的投标保证金； 2) 在签定采购服务合同之后，中标供应商要求解除合同的，没收中标供应商的履约保证金；		

		3) 签订合同后不履行其投标承诺的，没收中标供应商的履约保证金； (2) 因中标供应商原因发生重大安全事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关管理办法规定执行。同时，采购人有权保留终止合同的权利，并报相关行政主管部门处罚。 (3) 如遇突发或紧急事件，采购人有权要求中标人进行适当的人员调配，中标人须在 30 分钟内对采购人需求作出响应，若因中标人原因无法及时安排现场人员到岗，给采购人造成的损失由中标人承担。 (4) 在签定服务合同之后，中标人提供的服务人员不符合本合同约定的任职条件的，采购人有权提出更换不称职的服务人员，中标人不得以任何理由推诿，否则，采购人有权保留终止合同的权利，并报相关行政主管部门处罚，给采购人造成的损失由中标人承担。 (5) 若一年内出现 3 次考评不合格，并限期内仍未整改完善的或整改不合格的，采购人有权保留终止合同的权利，并报相关行政主管部门处罚，给采购人造成的损失由中标人承担。 (6) 中标人不得转包、分包及挂靠，若发现转包、分包及挂靠行为，采购人有权解除合同，并追究相关法律责任，且没收履约保证金。 (7) 在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。 投标人需上述 7 项违约条款出具专项承诺(独立出具)，否则视为无效投标。 9、知识产权
--	--	--

		中标人须保障采购人在使用该服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。 10、本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。 11、仲裁、诉讼条款 因采购或与采购合同有关的一切事项发生争议，由采购人和中标人双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向福州市仲裁委员会申请仲裁。
--	--	---

附件：技术要求

（一）服务范围及岗位要求

本次招标服务范围含平潭综合实验区医院新院区及老院区。

- 1、新院区门诊楼；（项号 1）
- 2、新院区病房楼；（项号 2）
- 3、新院区影像楼；（项号 3）
- 4、新院区台胞中心；（项号 4）
- 5、新院区感染楼；（项号 5）
- 6、新院区动力楼；（项号 6）
- 7、新老院区绿化养护；（项号 7）
- 8、老院区住院部；（项号 8）
- 9、老院区门诊医技大楼；（项号 9）
- 10、老院区附属区域；（项号 10）

★11、项目标准工时人数不得低于 246.65 人（两院合计人数）。

（1）新院区服务人员标准工时数测算量

部门	测算标准工时人数
项目管理	6
保洁	111.21
运送	63.14
工程部	26.2
电梯员	7.8
共计	214.35

项目管理:

岗位名称	岗位人数	工作时间	每周工作天数	每天工作小时	标准工时人数	岗位说明
项目经理	1	8:00-12:00 13:00-17:00	5	8	1	负责整个项目管理(含新老院区)
领班	1	8:00-12:00 13:00-17:00	5	8	1	负责门诊楼及外围环境保洁
领班	1	8:00-12:00 13:00-17:00	5	8	1	负责台胞楼保洁
领班	1	8:00-12:00 13:00-17:00	5	8	1	负责病房楼保洁
领班	1	8:00-12:00 13:00-17:00	5	8	1	负责新院区运送
领班	1	8:00-12:00 13:00-17:00	5	8	1	专职全院医废管理,兼感染楼、影像楼、动力楼保洁
				小计	6	

保洁:

楼宇	楼层	科室内容	上班时间安排	上班	天数	岗位人员	标准工时人员	备注
门诊楼	4F	行政办公室、会议室	7:30-12:00 13:30-17:00	8	5.5	1	1.1	含党员活动室
		行政办公室、会议室、党员活动室						
	3F	内科、耳鼻喉科、眼科、	7:30-12:00	8	6	2	2.4	

		口腔科、多学科综合门诊/远程会诊中心、门诊检查室	13:30-17:00					
	2F	外科、皮肤科、抽血处、骨科、中医科、PICC、精神心理科	7:30-12:00 13:30-17:00	8	6	1	1.2	
		门诊手术室	7:30-12:00 13:30-17:00	8	5.5	1	1.1	含运送
		检验科	8:00-12:00 13:00-17:00	8	6	1	1.2	
		检验科（专职高压消毒工作）	8:00-12:00 13:00-17:00	8	7	0.5	0.7	须持有特种设备作业人员证
	1F	西药房、中药房、门诊收费处、住院收费处、门诊服务中心、住院服务中心、导诊服务中心、医保服务中心及大厅	7:00-12:00 13:00-17:00	8	7	1	1.4	
		公共区域、卫生间巡视	7:00-12:00 13:00-17:00	8	7	1	1.4	
		妇产科、康复科、儿科门诊	7:00-12:00 14:00-17:00	8	6	1	1.2	
	1-4F	公区、消防楼梯、卫生间巡视	7:00-12:00 14:00-17:00	8	7	1	1.4	
病房	17F	13 病区	未投入使用					
	16F	12 病区	1、7:10-12:10 14:00-17:00	8	7	2	2.8	含高干病房
			2、7:10-15:10					

楼	15F	11 病区, 呼吸内科病房/ 血液科病房	1、7:10-12:10 14:00-17:00	8	7	2	2.8	50 床位
			2、7:10-15:10					
	14F	10 病区, 内分泌科病房/ 神经内科病房	1、7:10-12:10 14:00-17:00	8	7	2	2.8	50 床位
			2、7:10-15:10					
	13F	9 病区, 消化内科病房/ 肿瘤内科病房	1、7:10-12:10 14:00-17:00	8	7	2	2.8	50 床位
			2、7:10-15:10					
	12F	8 病区, 心血管内科病房 /肾内科病房	1、7:10-12:10 14:00-17:00	8	7	2	2.8	50 床位
			2、7:10-15:10					
	11F	7 病区, 骨科病房	1、7:10-12:10 14:00-17:00	8	7	2	2.8	50 床位
			2、7:10-15:10					
	10F	6 病区	未投入使用					
	9F	5 病区, 泌尿外科/耳鼻 喉科/眼科/口腔科病房	1、7:10-12:10 14:00-17:00	8	7	2	2.8	50 床位
			2、7:10-15:10					
	8F	4 病区, 神经外科(颅脑 脊柱外科)病房	1、7:10-12:10 14:00-17:00	8	7	2	2.8	50 床位
			2、7:10-15:10					
	7F	3 病区, 普外科病房	1、7:10-12:10 14:00-17:00	8	7	2	2.8	50 床位
			2、7:10-15:10					
	6F	2 病区	1、7:10-12:10 14:00-17:00	8	7	2	2.8	兼 17 楼卫生

			2. 7:10-15:10					
	5F	血液净化中心	8:00-18:00	10	6	2	3	含运送
	4F	病案室、公共区域						
		DSA（介入导管室）	7:30-11:30 13:00-17:00	8	5.5	1	1.1	含运送。病案及公共区域。卫生间
	3F	1 病区，重症医学科	7:30-11:30 13:00-17:00	8	7	2	2.8	
	2F	内镜中心及公共区域	7:30-12:00 13:30-17:00	8	5.5	2	2.2	含运送。科室等候区。卫生间
		B 超科及科内公共区域	7:30-12:00 13:30-17:00	8	5.5	1	1.1	含科内领物资
	1F	中心药房及公共区域	7:30-11:30 13:00-17:00	8	6	1	1.2	
		静脉用药调配中心						
		职工食堂、小卖部	不负责					
	B1F	营养食堂、库房	不负责					
	1-17 F	消防楼梯巡视及公区	7:30-11:30 13:00-17:00	8	7	1	1.4	保洁及电梯厅巡视
台胞楼	8F	21 病区	未投入使用					
		20 病区	未投入使用					
	7F	19 病区，妇产科病房	7:10-11:40	4	7	0.5	0.7	兼 8 楼卫生
		18 病区，妇产科病房（产前）	7:10-11:40 13:30-17:00	8	7	1	1.4	床位 28
	6F	17 病区，新生儿监护病房	7:30-11:30 13:00-17:00	8	7	1	1.4	

		16 病区, 儿科病房	1、7:30-11:30 14:00-17:00 2、7:00-15:00	8	7	2	2.8	床位 42
	5F	15 病区, 妇产科病房	1、7:10-11:40	4	7	0.5	0.7	
		14 病区, 妇产科病房(产后)	1、7:10-11:40 13:00-17:00	8	7	1	1.4	床位 42
			2、7:00-15:00					
	4F	产房、产科手术室						工作量测在运送服务
	3F	麻醉手术部						工作量测在运送服务
	2F	消毒供应中心	8:00-12:00 13:00-17:00	8	7	2	2.8	
		输血科	8:00-12:00 13:00-17:00	8	7	1	1.4	
		健康管理中心(体检)	8:00-12:00 13:00-17:00	8	5.5	1	1.1	
	1F	台胞服务大厅、急救中心、急诊收费处、急诊药房、抢救室、放射科(CT/DR 检查室)、输液大厅	7:30-11:30 13:00-17:30	8	7	2.5	3.5	运送驻守员工兼部分保洁工作含愿检尽检应检尽检保洁
		急诊病房	7:30-11:30 13:00-17:30	8	7	1	1.4	
	1-8F	消防楼梯巡视及公区	7:30-11:30 13:00-17:00	8	7	1	1.4	
感	7F	26 病区, 感染科病房	7:30-11:30	8	7	1	1.4	3-7 楼保洁及 2

染楼			13:00-17:00					楼清洁区卫生
	6F	27 病区, 感染科病房						
	5F	28 病区, 感染科病房	未投入使用					
	4F	29 病区, 感染科病房	未投入使用					
	3F	30 病区, 感染科病房	未投入使用					
	2F	31 病区, 感染科病房 (PCR)						
		31 病区, 感染科病房 (PCR) (专职高压消毒工作)	7:30-12:00 13:30-17:00	8	7	0.5	0.7	须持有特种设备作业人员证
	1F	发热门诊	全天 24 小时	8	7	4	5.6	含二楼 PCR 保洁及运送
影像楼	3F	病理科	8:00-12:00 13:00-17:00	8	5.5	1	1.1	
	2F	影像科办公室	未投入使用					
	1F	MR 室、CT 室、DR 室、数字肠胃室、乳腺钼靶室	7:30-12:00 13:30-17:00	8	6	1	1.2	
动力楼	2F	设备科、总务科、信息科、基建科等	7:30-12:00 13:30-17:00	8	5.5	0.25	0.28	
	1F	消控中心、机房、水泵房等	7:30-12:00 13:30-17:00	8	5.5	0.25	0.28	
全院	B1F-2F	地下停车场保洁工作	7:30-12:00 14:00-17:30	8	7	2	2.8	含全院电梯疫情消毒登记加手消
	外围	外围保洁 1	7:00-17:00	10	7	2	3.5	含中午班
	中班	班外时间应急保洁						
	下夜	夜班应急保洁 (22:00 过	17:-7:00	14	7	1	2.45	

	班	后保洁)						
专 项 人 员		玻璃清洁/灯具风口		8	6	2	2.4	含不锈钢, 院 内搬家具
		机器洗地		8	7	4	4.2	兼院内搬家具
		PVC、大理石维护保养		8	6	2	2.4	兼院内搬家具
		生活垃圾收集		8	7	2	2.8	
		医疗垃圾收集		8	7	2	2.8	
		不锈钢保养						测算在玻璃清 洁
		仓库管理人员及洗布草 人员		8	7	1	1.4	
		年假替班		8	5	2	2	
						小计	111.21	

运送:

序 号	职位	科室内容	上班时间安排	每天 上班 时间	天数	岗位 人员	标准 工时 人数	备注
1	调度	调度	8:00-12:00 14:00-18:00 (8H)	8	7	1	1.4	
2			7:00-15:00 (8H)	8	7	1	1.4	
3			23:00-7:00 (8H)	8	7	1	1.4	兼员工应急岗
4	驻守	门诊1楼中药 房与西药房	8:00-12:00 13:30-17:00 (7.5H)	7.5	6	1	1.13	将药品由药库送至 药房、拆包装、上 架、整理药柜
5		门诊2楼门诊						

		手术室(测量在保洁)						
6		门诊2楼检验科	8:30-12:00 13:00-17:00(7.5H)	7.5	7	1	1.31	标本送达签收、清洗试管、分拣送报告单、领物、(行政、器械、外用药)
7		门诊3楼检查室	8:00-12:00 14:00-17:00(7H)	7	6	1	1.05	周一至周六7H;病人分诊、领物、分拣报告,送文件
8		门诊1-3楼门诊科室及门诊手术室	7:30-12:00 14:00-17:00(7.5H)	7.5	7	1	1.31	临时病人运送、棉织品清点、送标本、取送物品到供应室、领物(行政、器械、外用药)、紫外线灯管擦拭
9		台胞楼1楼急诊抢救室	7:00-15:00(8H)	8	7	1	1.4	24小时驻守,班外时间兼顾保洁
10			15:00-23:00(8H)	8	7	1	1.4	
11			23:00-7:00(8H)	8	7	1	1.4	
12		台胞楼1楼急诊病房	8:00-12:00 13:30-17:30(8H)	8	6	1	1.2	周一至周六7.5H,周日由急诊抢救室员工兼并
13		台胞楼1楼放射科	8:00-12:00 14:00-17:00(7H)	7	6	1	1.05	周一至周六7H;病人分诊、领物、分拣报告,送文件
14		台胞楼2楼供应室	8:00-12:00 13:00-17:00(8H)	8	7	1	1.4	高压运送
15			8:00-12:00	8	7	1	1.4	消毒物品上收下

			13:00-17:00 (8H)					送、洗送工作服、领物
16		台胞楼 3 楼麻醉手术室(含保洁工作量)	7:30-17:30 (10H)	10	6	1	1.5	周一至周六
17			7:30-17:30 (10H)	10	6	1	1.5	保洁. 运送统筹使用
18			7:30-17:30 (10H)	10	6	1	1.5	周一至周六
19			7:30-17:30 (10H)	10	6	1	1.5	保洁. 运送统筹使用
20			7:30-17:30 (10H)	10	6	1	1.5	周一至周六
21			7:30-17:30 (10H)	10	6	1	1.5	保洁. 运送统筹使用
22			17:30-7:30 (14H)	14	7	1	2.45	保洁. 运送统筹使用
23			7:30-17:30 (10H)	10	1	1	0.25	周日一天白班
24		台胞楼 4 楼产房、产房手术室(含保洁工作量)	0:00-24:00 (24H)	24	7	1	4.2	含运送, 科室等候区保洁
25			7:30-11:30 (4H) 根据科室实际需要增加早班一个	4	7	1	0.7	
26		病房楼 1 楼静配中心	7:30-17:30 中间休 1 小时 (9H)	0		0	0	将药品由药库送至药房、拆包装、上架、整理药柜、全院药品下送、领物
27			7:30-17:30 中间休 1 小时 (9H)	0		0	0	
28			7:30-17:30 中间休 1 小时 (9H)	0		0	0	
29		病房楼 1 楼中心药房	8:30-12:30 14:00-17:00 (8H)	8	7	1	1.4	将药品由药库送至药房、拆包装、上架、整理药柜、领

								物
30		病房楼 2 楼超声科						测算在运送导诊组
31		病房楼 2 楼内镜中心						测算在保洁
32		病房楼 3 楼 ICU						测算在即时人员
33								
34								
35		病房楼 4 楼 DSA (测量在保洁)						
36		病房楼 5 楼血液净化中心(测量在保洁)						
37		影像楼 1 楼检查室						测算在台胞楼一楼放射科
38		感染楼 1 楼发热门诊	8:00-12:00 14:00-17:00 (7H)	7	6	1	1.05	非疫情期间要求测量
39	循环组	2 区、3 区、4 区、5 区、25 区、26 区	8:00-12:00 13:00-17:00 (8H)	8	7	1	1.4	增加 2 区。12 区。 调整周一至周日
40		7 区、8 区、9 区、10 区、11 区、12 区	8:00-12:00 13:00-17:00 (8H)	8	7	1	1.4	
41		14 区、15 区、16 区、17 区、18 区	8:00-12:00 13:00-17:00 (8H)	8	7	1	1.4	
42		全院病区	12:00-14:00	7	7	1	1.23	周一至周日班外时

			17:00-22:00 (7H)					间收送标本. 设双 人岗测算在即时人 员
43		3 区、4 区、5 区、7 区、8 区、 9 区、25 区、2 6 区	周日收送标本、文 件、预约单, 与序号 40 员工合并排班					测算在 40
44		10 区、11 区、1 4 区、15 区、1 6 区、17 区、1 8 区	周日收送标本、文 件、预约单, 与序号 41 员工合并排班					测算在 41
45	导 诊 组	2 区、3 区、4 区、 5 区、25 区、2 6 区	8:00-13:00 13:30-16:30 (8H)	8	6	1	1.2	周一至周六负责区 域内病人运送
46			8:00-12:00 13:00-17:00 (8H)	8	7	1	1.4	周一至周日负责区 域内病人运送
47		7 区、8 区、9 区、10 区、11 区	8:00-13:00 13:30-16:30 (8H)	8	6	1	1.2	周一至周六负责区 域内病人运送
48			8:00-12:00 13:00-17:00 (8H)	8	7	1	1.4	周一至周日负责区 域内病人运送
49		14 区、15 区、1 6 区、17 区、1 8 区	8:00-13:00 13:30-16:30 (8H)	8	6	1	1.2	周一至周六负责区 域内病人运送
50			8:00-12:00 13:00-17:00 (8H)	8	7	1	1.4	周一至周日负责区 域内病人运送
51		全院病区	17:00-22:00 (5H)	5	7	1	0.88	周一至周日负责病 人运送, 与序号 32 员工合并排班
52	计划	文件运送 (送检)						

	组	查预约单并预约、取送功能检查报告等)						
53		盐水运送及上架、送空血袋到血库	8:00-12:00 14:00-17:00 (7H)	7	6	1	1.05	周一至周六, 全院驻守科室除外
54		领物行政、器械、外用药、运送设备清洁、紫外线灯管消毒	8:00-12:00 14:00-17:00 (7H)	7	6	1	1.05	周一至周六, 全院驻守科室除外
55		班外取药	12:00-14:00 17:00-22:00 (7H)	7	7	1	1.23	周一至周日
56		取送净、污棉织品送洗衣房并清点						由外包洗涤公司负责
57		值班被棉织品更换	7:00-12:00 14:00-17:00 (8H)	8	7	1	1.4	周一至周日
58	中心	即时人员	7:00-15:00 (8H) 舍全院班外双岗运送	8	7	2	2.8	周一至周日
59		即时人员	15:00-23:00 (8H) 舍全院班外双岗运送	8	7	2	2.8	周一至周日
60		即时人员	23:00-7:00 (8H) 舍全院班外双岗运送	8	7	1	1.4	周一至周日
						小计	63.14	

电梯员：

楼宇	岗位名称	岗位人数	岗位时间段	每周工作天数	每天工作小时	标准工时人数
门诊楼	一楼扶梯引导员	1	8:00-12:00 13:00-17:00	5.5	8	1.1
	电梯安全巡逻员	1	8:00-12:00 13:00-17:00	5.5	8	1.1
台胞楼	手术专梯	1	0:00-24:00	7	24	4.2
	一楼电梯厅引导员					
病房楼	手术专梯	1	8:00-12:00 13:00-17:00	7	8	1.4
	1#电梯厅引导员					
					小计	7.8

工程部：

岗位名称	岗位人数	工作时间	每周工作天数	每天工作小时	标准工时人数	岗位说明
高压电工	2	0:00-24:00	7	24	8.4	高压电工:须持有高电工作业证书, 高低压配电 24 小时值班, 发电机房日常维护保养, 定期试运行和应急发电供电有记录, 3 个高低压配电房巡查记录、楼层电井的巡检。屋面风机检修
普通电工	4	0:00-24:00 8:00-12:00	7	32	5.6	水电维修工:24 小时值班, 负责全院的水、电、灯具、水暖用具的维护维修,

		14:00-17:00				保障用电用水正常。做好全院相关设施的巡查及日常维护,外围路灯及部分增改造安装任务,楼层电气开关、照明、水泵动力柜等维护维修。兼金井宿舍,钳工维修。
领班	1	8:00-12:00 13:00-17:00	5	8	1	兼普通电工。污水站维修
污水处理员	2	8:00-12:00 13:00-17:00	7	8	2.8	给水泵房、污水处理的运行、保养与巡检,给排水等运行与应急维修。
综合维修工	3	8:00-12:00 13:00-17:00	6	8	3.6	负责各楼屋面排气风机每天巡检一次,负责全院所有给排水管道及水龙头、阀门、水泵、潜水泵的保养与日常维修,疏通下水道。
绿化养护工	3	8:00-12:00 13:00-17:00	6	8	3.6	负责全院绿化养护,植树、修剪、施肥、锄草、浇水、枯枝落叶清理,持有花卉园艺师证书。
泥水油漆工	1	8:00-12:00 13:00-17:00	6	8	1.2	负责地面、墙壁、天花的简单翻新及修补;负责机房地面、管道、设备的刷漆,同老院统筹使用
				小计	26.2	

(2) 老院区标准工时人数测算

部门	标准工时人数	备注
项目管理	1	
保洁	18.6	
运送	2	
工程部	10.7	含电梯工
共计	32.3	

项目管理:

岗位名称	岗位人数	工作时间	每周工作天数	每天工作小时	标准工时人数	岗位说明
领班	1	8:00-12:00 13:00-17:00	5	8	1	负责老院区保洁及运送服务
				小计	1	

保洁:

楼宇	楼层	科室内容	上班时间安排	每天上班 时间	天数	岗位 人员	标准工 时人员	备注
门诊楼	4F	心理咨询室、办公室、病案室						
	3F	中医科、中药库、中药房						
		门诊手术室						
	2F	内科、妇产科、外科、骨科、神外、泌尿外、泌外专家、西药房、儿科、儿科专家、门诊抽血室、门诊化验室、康复科、行政办公室						
	1F	门诊收费处、服务中心、大厅、行政办公						

		室、发热门诊、公共卫生间、急救中心						
住院部	9F	病区	8:00-12:00 13:30-17:30	8	6	1	1.2	含 4、6-9 楼保洁
	8F	病区						
	7F	病区						
	6F	病区						
	5F	内科综合病房	18:00-12:00 14:30-17:30	8	7	2	2.8	
	4F	总医院办公室 病案室						
	3F	病区						
	2F	病区						
	1F	住院部大厅、收费窗口、取药窗口、中心药房、门急诊药房、西药房、库房						
	1-9F	消防楼梯、公区巡视						测算在全院外围
门诊医技楼	9F	精神病区	7:30-12:00 14:00-17:30	8	7	1	1.4	
	8F	精神病区	7:30-12:00	8	7	1	1.4	

			14:00-17:30					
	7F	肿瘤科研中心						测算在心身病区
	6F	心身病区	7:30-12:00 14:00-17:30	8	7	1	1.4	床位 35
	5F	检验科	7:30-12:00 14:00-17:30	8	7	1	1.4	
	4F	内科门诊. 儿科门诊. 中医科门诊. 康复科	7:30-12:00 14:00-17:30	8	6	1	1.2	
	3F	信息科	未投入使用					测算在二楼
	2F	门诊采血室. CT. 拍片. 精神科门诊	8:00-12:00 13:30-17:30	8	6	1	1.2	
	1F	门诊收费处. 便民门诊. 肝炎门诊. 发热门诊核酸采样点	8:00-12:00 14:30-17:30	8	6	1	1.2	兼病房楼 1 楼大厅 保洁
供应室		西药房	8:00-12:00 14:30-17:30	8	6	1	1.2	
全院	外围、地下室	外围保洁 1、地下室保洁	7:30-12:00 14:00-17:30	8	7	1	1.4	
专项人员	全院	玻璃清洁/灯具风口/墙面		8	7	1	1.4	含院内家具搬运
		机器洗地						
		水磨石保养						
		生活垃圾收集		8	7	0.5	0.7	

		医疗垃圾收集		8	7	0.5	0.7	
		年假替班						
管理 人员	全院	领班						
		主管						
		经理（保洁、运送）						
						小计	18.6	

运送：

序号	职位	岗位	时 间	每天 上班 时间	上班 时间	标准工 时人数	备注
1	中心	即时人员	7:00-15:00	8	5	1	周六周天测算 在保洁
2		即时人员	15:00-23:00	8	5	1	周六周天测算 在保洁
					小计	2	

工程部：

岗位名称	岗位 人数	工作时间	每周 工作 天数	每天 工作 小时	标准 工时 人数	岗位说明
高压电工	2	0:00-24:00	7	48	8.4	高压电工：须持有高电工作业证书，高低压配电 24 小时值班，发电机房日常维护保养，定期试运行和应急发电供电有记录,2 个高低压配电房巡查记录、楼层电井

						的巡检。屋面风机检修。
普通电工		测算在高压电工				水电维修工：24 小时值班，负责全院的水、电、灯具、水暖用具的维护维修，保障用电用水正常。做好全院相关设施的巡查及日常维护，外围路灯及部分增改造安装任务，楼层电气开关、照明、水泵动力柜等维护维修。
综合维修工		测算在新院工程部				给水泵房、污水处理的运行保养与巡检；负责项目巡检及所有给排水管道及水龙头、阀门、水泵、潜水泵的保养与日常维修、下水管道疏通。
绿化养护工		测算在新院绿化养护工				负责全院绿化养护，植树、修剪、施肥、锄草、浇水、枯枝落叶清理，持有花卉园艺师证书。
电梯司机	1	8:00-12:00 14:00-18:00	5.5	8	1.1	电梯安全巡逻员
泥水油漆工	1	8:00-12:00 14:00-18:00	6	8	1.2	负责地面、墙壁、天花板的简单翻新及修补；负责机房地面、管道、设备的刷漆。同新院统筹使用
				小计	10.7	

★注：投标人在投标文件中提供各院区、各部门详细的人员配置情况。该项目存在不可预见增加服务人员的情况，超过服务费 3%以内（含 3%）的不予以增加服务费，超出 3%以外的服务费由采购人支付，投标人须提供承诺函。

要求：上述人数为项目运行中实际配置的最低人数，如投标人在投标文件中所设置的人数少于上述要求，则视为未实质响应招标文件要求，作废标处理。

（二）保洁服务要求（含绿化养护）

保洁工作包括日常清洁、消毒工作及专项清洁（不包含开荒保洁），以满足医护人员、病人对环境保洁的基本需求，而专项清洁则是为更好满足需求而做的进一步服务，同时专项清洁对内建筑的维护保养，延长其使用寿命方面发挥着重要作用。（项号 11）

1、日常清洁

▲（1）重点清洁

每日 1 次用清水或全能清洁剂对物体表面进行擦拭，除去浮尘，如床单位：床、床架、桌、椅、台面、窗台等物表擦拭（医用精密仪器治疗机器除外，如麻醉机、床边拍片机、吸痰器等；治疗室指定存放药品的药柜、抽屉内部除外）。

每日 1 次用清水或全能清洁剂对墙壁、门和门框进行重点清洁，及时擦掉手印和污迹。

（2）地面清洁（项号 12）

每日 2 次用牵尘液处理过的尘推布头除去地面的垃圾、尘土、沙粒。

每日 1 次用清水或清洁剂及干净的、消毒剂处理过的布头湿拖地板，除去地面的污渍。

对地面难处理的污渍进行局部处理。

（3）清洁垃圾桶和烟灰缸（项号 13）

垃圾桶和烟灰缸，室内每日 2 次；公共区域及时倒净。

用全能清洁剂擦拭垃圾桶及烟灰缸的表面，做到表面清洁、无污渍、光亮。

必要时换掉垃圾桶的衬里，并对垃圾桶的内部进行清洁。

（4）清洁卫生间及浴室（项号 14）

每日 1 次对水池和马桶的内外侧进行清洁和消毒。

每日 1 次擦拭卫生间的镜子、五金件及台面，保证其清洁度和光亮度。

每日 1 次对卫生间的地面进行湿拖、刷洗。

（5）清洁风口（项号 15）

每周 1 次各手术间、ICU 的送风口擦拭。

每日 1 次出风口擦拭（出风口过滤网每周擦拭一次除外，由院外包工完成）。

（6）使用毛巾、洁具（项号 16）

不同区域的毛巾分类使用及其他洁具如拖把、水桶等分开使用。同一区域的毛巾使用一床一巾；一房一巾。

2、消毒工作

具体要求和技术规范如下：

▲（1）对各手术室、产房及隔离产房、烧伤科、各 ICU、各换药室、出院病人床单位及隔离病房，1 日 1 次使用 0.05%（500mg/L）含氯消毒剂对物表、地面进行拖擦。手术后或出现污染时应随时清洁，具体消毒方法参照（3）进行。

（2）有多重耐药菌感染患者区域的洁具专用，1 日 1 次使用 0.1%（1000mg/L）含氯消毒剂对物表、地面进行拖擦（每人使用的平车、轮椅由运送专人负责）。有呕吐物、排泄物、血液等体液污染时，具体消毒方法参照（3）进行。（项号 17）

（3）当各科室用品表面或地面受到病人呕吐物、排泄物、血液等体液明显污染时，应立即采用 0.2%（2000mg/L）含氯消毒剂作用 30 分钟进行消毒，作用后用清水擦拭，应严格执行一床一巾的程序。（项号 18）

（4）对于实验环境下的消毒，如检验科、抽血室、同位素、各研究所室的日常消毒，物表、地面采用 0.05%（500mg/L）500mg/L 含氯消毒剂擦拭，若有明确的污染，如标本外溢或器皿打破，应立即用 0.2%（2000mg/L）2000mg/L 含氯消毒剂喷洒作用 30 分钟，再行清水擦拭处理。（项号 19）

(5) 每月 1 次用 75%酒精擦拭紫外线灯管，用清水擦拭紫外线灯罩外壳。（紫外线灯手可及处由保洁员完成，高处由运送员完成）（项号 20）

备注：工作人员注意个人防护穿戴措施。

3、专项清洁

(1) 墙面清洁：使用专业工具每季度一次对通道及室内墙面进行彻底的清洁。（项号 21）

(2) 灯具、风口、天花的清洁：5 月至 10 月每月一次风口保洁，其它月份每季度一次对灯具、风口、天花进行彻底的清洁。（项号 22）

(3) 玻璃清洁：使用专业玻璃清洁工具、药剂，对门厅玻璃每天一次，病房及其它区域每月一次的频率进行玻璃清洁，以保证玻璃洁净、透亮。（项号 23）

(4) 不锈钢制品的清洁、保养：对所有不锈钢制品（包括电梯门）以每天一次除尘和重点清洁，每周一次抛光除渍，每半月一次上不锈钢油保养的方式进行清洁保养。以防止不锈钢氧化、生锈，保证不锈钢的清洁度和光亮度。（项号 24）

(5) 硬地面的清洁、维护：（项号 25）

PVC 地面：使用专业机器和地板抛光液，以每周一次的频率进行抛光，除去人力难以除掉的污渍，恢复地板的光亮并消毒。每 60 天一次刷洗补蜡，彻底清除表面的污渍、细菌，并及时为 PVC 地面覆盖保护层，防止地面被划伤或磨损，同时提高地面的光亮度。

水磨石、花岗岩、大理石地面：使用专业机器和地面翻新、晶化药剂，对地面进行翻新处理，以每两周一次的频率进行晶化保养，恢复和保持地面光亮。

地砖地面：使用专业洗地机和清洁剂（针对洗地机能到达和方便使用的区域），以每 2 周一次的频率对地面进行全面清洗和消毒。

4、绿化养护

▲中标人负责对全院范围内的绿植养护工作，包括浇水、修剪、除杂草、施肥（医院提供肥料）、虫害防治（医院提供药剂）及枯枝、落叶清理等日常维护工作。补种、移栽、盆栽、摆放花卉等由医院负责；

5、开荒服务

★中标人须根据采购人需求，及时安排人员对采购人营业地址的建筑、楼层进行开荒服务，所需费用已包含在本项目预算金额中，须提供承诺函，格式自拟。

（三）中央运送服务

1、中标人在院内建立二十四小时的中央调度中心，对运送员工和运送工作进行科学的分工，通过对全体员工进行运送方式的分工为全院的病人、检查单、标本、文件、单据、药品等医疗物资和物品提供二十四小时的服务。（项号 26）

▲2、运送部服务范围的说明

区域	运送服务范围	非运送服务范围	备注
病	常规收送化验标本 （临时）收送化验标本 领取信件和报纸 运送资料等 取化验结果 送病人院内检查 协助护士为病人转科、转床 领办公用品、医疗消耗品 （临时）领办公用品、医疗消耗品 供应室取消毒物品 （临时）到供应室取消毒物品 送消毒包到供应室 分发并收集陪伴床	1、领麻醉药 2、班内领西药 3、无医护人员指导独立运送术后病人 4、退药 5、医疗器械擦拭 6、为医护人员办私事 7、库房整理 8、取血	

区	换氧气 领中成药 协助护士领药 领消毒液 领盐水 领外用药 领桶装蒸馏水 盐水瓶上架，送空盐水瓶，收集空盐水瓶 班外领西药 小型医疗设备送修 小型医疗设备的借用、送还 收集医疗垃圾并送到指定地点 给病人发送饮用热水 值班床上用品更换 擦拭消毒氧气架 擦拭消毒病历车、病历夹 擦拭消毒轮椅和平车 给各种车辆清洗线头并加润滑油 用酒精擦拭紫外线灯（高处） 被服换季整理，翻晒 科室物品送修		
门	常规收送化验标本、单据 领取信件和报纸 送资料等 领办公用品、医疗消耗品 供应室取消毒物品		

诊	(临时) 到供应室取消毒物品 送消毒包到供应室 领消毒液 领外用药 小型医疗设备送修 小型医疗设备的借用、送还 收集医疗垃圾并送到指 定地点 值班床上用品更换 擦拭消毒轮椅和平车 给各种车辆清洗线头并加润滑油 用酒精擦拭紫外线灯 (高处) 科室物品送修 运送行动不便的病人入院		
急	常规收送化验标本 (临时) 收送化验标本 取化验结果 送资料等 领取信件和报纸 送病人院内检查 协助护士为病人转科 领办公用品、医疗消耗品 临时 (领办公用品、医疗消耗品) 供应室取消毒物品 (临时) 到供应室取消毒物品 送消毒包到供应室 班外领西成药	1、领麻醉药 2、领西药 3、取血 4、退药 5、医疗器械擦拭	

诊	领消毒液 领外用药 小型医疗设备借用、送还、送修 收集医疗垃圾并送到指定地点 盐水瓶上架，送空盐水瓶 急诊中夜班 值班床上用品更换 擦拭消毒氧气架 擦拭消毒病历车、病历夹 擦拭消毒轮椅和平车 给各种车辆清理线头并加润滑油 用酒精擦拭紫外线灯（高处） 换氧气 科室物品送修		
手 术 室	送冰冻/病理片 接送手术病人进手术室 接送病人回病房 领办公用品、医疗消耗品 文件运送 领取信件和报纸 供应室取消毒物品 送消毒包到供应室 领消毒液 领外用药 领盐水、整空瓶、送盐水瓶 小型医疗设备的运送	1、领麻醉药 2、为医护人员办私事 3、取血	

	小型医疗设备的送修 收集医疗垃圾并送到指定地点 洗拖鞋 洗医务人员的擦手毛巾 值班床上用品的更换 擦拭消毒平车 给各种车辆清理线头并加润滑油 擦拭消毒脚凳、踏、地垫 医生办公室卫生清洁 公共区域卫生清洁（3楼） 各库房卫生清洁 夜班值班 18:00—7:30 紫外线灯消毒 科室物品送修		
ICU	接送病人回病房 领办公用品、医疗消耗品 运送资料等 领取信件和报纸 供应室取消毒物品 送消毒包到供应室 领消毒液、外用药 领盐水、整空瓶 送盐水、整空瓶 送盐水瓶 小型医疗设备的运送 小型医疗设备的送修 收集医疗垃圾并送到指定地点	1、领麻醉药 2、取血 3、退药 4、为医护人员办私事	这些区域的保 洁、运送工作都 由驻守员工完 成。

	洗拖鞋 洗医务人员的擦手毛巾 值班床上用品的更换 擦拭消毒治疗车 擦拭消毒平车 给各种车辆清理线头并加润滑油 擦拭消毒脚凳、踏、地垫 医生办公室卫生清洁 公共区域卫生清洁 各库房卫生清洁 紫外线灯消毒 科室物品送修		
药 房	领办公用品 运送资料 领取信件和报纸 值班床上用品的更换 擦拭消毒治疗车 各库房卫生清洁 紫外线灯消毒 科室物品送修 药品拆箱、药品上架 药品层架清洁 药房内处专项外所有卫生保洁	1、药品出、入库管理	
检	运送资料 领取信件和报纸 领办公用品		

（四）工程服务

▲1、服务内容

服务岗位	服务内容
高压电工	新老院区高低压配电 24 小时值班，包括新老院区发电机房、高低压配电房、楼层电井的巡检；
普通电工	24 小时值班，负责全院的电路、水路、灯具、水暖用具的维护维修，保障用电用水正常。做好全院相关设施的巡查及日常维护，外围路灯及部分新增改造安装任务，楼层电气开关、照明、水泵动力柜等维护维修。
综合维修工	负责给水泵房、污水处理的运行保养与巡检；负责各楼屋面排气风机巡检（每天一次）；负责项目巡检及所有给排水管道及水龙头、阀门、水泵、潜水泵的保养与日常维修、下水管道疏通。
绿化养护工	负责全院绿化养护，植树、修剪、施肥、锄草、浇水、枯枝落叶清理，持有花卉园艺师证书。
泥水油漆工	负责地面、墙壁、天花板的简单翻新及修补；负责机房地面、管道、设备的刷漆。
备注	所有运行、操作必须严格按照操作规程进行，否则出现事故由中标供应商负责。

★2、所有岗位的人员必须按照国家、政府或行业的规范持证上岗，需提供承诺函，格式自拟。

（五）后勤物业管理服务相关要求

设立 24 小时的中央调度中心，配置相关软件对人员调度、工作量等进行综合管理。（项号 27）

1、环境保洁

（1）负责医院范围内工作区域（不含库房、机房及约定不能进入的场所）的保洁。（项号 28）

（2）严格按照《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《医疗废物管理条例》规定，及时收集生活垃圾和医疗垃圾，并送到院内指定地点。（项号 29）

（3）按时巡视，每层从屋顶到墙壁到地板要做到干净、整洁，无蜘蛛丝，无烟头、无纸屑、无痰迹；卫生间要清洁、干燥、无异味。（项号 30）

（4）为避免尘土飞扬，地面干拖应使用尘推加牵尘剂的方法进行处理。（项号 31）

（5）要求对尘推头和抹布用专门的工业洗衣机和烘干机进行洗涤和烘干，不能用手洗，以防止交叉感染。（项号 32）

（6）为防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按医院感染管理的要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分。（项号 33）

（7）做好环境保洁区域内的所有 PVC 地面/橡胶、水磨石、大理石、花岗岩等地板的养护。（项号 34）

（8）要求中标人对医院的项目管理配置专用的洗地机、自动洗地吸水机、抛光机、吸水洗尘机、地坪/地毯吹干机、真空吸尘机、对讲机、工业用洗衣机和烘干机、垃圾车、榨水器、不锈钢桶、电脑、打卡钟和打印机等。（项号 35）

（9）中标人提供保洁用的清洁剂、洗涤剂、消毒剂和地面保护材料，这些消耗品必须是通过国家相关权威机构审批准予使用，并符合医院院感科的要求，并且要求提供优质的产品。（项号 36）

（10）所使用的清洁车辆必须是先进的全方位清洁手推车。（项号 37）

(11) 医院提供办公场地、放置员工更衣柜的场所。(项号 38)

(12) 中标人负责其员工的工服, 抹布和墩布的洗涤和烘干等工服(医院无偿提供洗衣场所、水、电, 但洗涤设备费用要由中标人自行负责)。(项号 39)

(13) 报价中应包含 PVC 地面的护理, 包括打蜡, 喷磨和抛光等处理, 保持 PVC 地面的光亮、整洁, 并且注明保养的频率。(项号 40)

(14) 要求对环境保洁进行科学的划分, 并且强调规范化管理。(项号 41)

(15) 中标人负责提供洗涤墩布的设备, 医院方免费提供放置该设备的空间及相关设施(水电气, 排水设施)。(项号 42)

(16) 医院无偿提供办公场地及服务设备场所使用的水、电。(项号 43)

(17) 中标人自行负责提供手套、口罩、帽子、胶鞋、鞋围裙等防护用品, 提供办公家具和更衣柜。垃圾袋、垃圾容器、锐器盒由医院提供。(项号 44)

2、中央运送

(1) 设立 24 小时的中央调度中心, 配置相关软件对人员调度、工作量等进行综合管理。(项号 45)

(2) 中标人自行负责提供电脑、打卡钟和打印机等办公设备。(项号 46)

(3) 中标人自行负责提供员工的工服。(项号 47)

(4) 医院负责提供运送用工具, 纳入固定资产, 中标人应合理调配并负责管理和保养。(项号 48)

(5) 要求对运送的数据进行汇总和统计, 能随时提供相应的数据, 给院方的决策进行支持。(项号 49)

(六) 服务质量标准

1、保洁部服务质量标准:

以下区域都可使用定制的保洁方法和频率中的一种或几种结合起来进行服务, 其中一些区域可使用适用于该区域特定环境的相应方法进行服务, 以达到需求的标准。

(1) 入口和大厅（以下为班内时间保洁频率）

▲1) 保持地面干净，每 30 分钟巡视一次，清扫地面烟头和废弃物；每日一次湿拖地面；每 3 天一次机器刷洗。

2) 每日一次清洁大厅入口处的玻璃，去除玻璃上的手印；每月一次专项全面清洗。
(项号 50)

3) 保持脚垫干净整洁，无明显沙土，无明显废弃物。每周冲洗一次。(项号 51)

4) 及时清理烟灰缸内的烟头和杂物，每日冲洗一次烟灰缸；每周清洗一次烟灰桶内胆。(项号 52)

5) 及时清洁金属门和金属护板。每日一次全面擦拭污迹；每月一次全面清洁抛光。
(项号 53)

(2) 病房/护士站/公用设施房/其他房间（以下为班内时间保洁频率）

1) 保持地面干净，无明显积尘，无明显废弃物，开水间地面无明显积水。每 180 分钟巡视一次病房，上午 9-11 点每小时巡视一次护理站；每日一次地面湿拖；每月一次地面专项保养。(项号 54)

2) 保持垃圾桶干净并套有干净的垃圾袋。每 240 分钟巡视病房垃圾桶一次；每 180 分钟巡视附属房垃圾桶一次；每日一次冲洗烟灰缸；每周一次清洗烟灰桶内胆。(项号 55)

3) 保持墙面干净，无明显污渍，每日一次巡查、清洁；每 3 个月一次全面清洁。
(项号 56)

4) 保持窗户干净，无明显污渍、手印，门窗顶部无积尘。当班中，每日一次巡查、清洁低处（手可及处）；每 2 个月一次全面专项清洁。(项号 57)

5) 保持家具干净，无明显黑尘、污迹，每日清洁一次。(项号 58)

(3) 卫生间（以下为班内时间保洁频率）

1) 保持座便器干净,无明显污渍。每日清洁一次;每周重点刷洗一次。(项号 59)

2) 按规定频率完成卫生间刷洗清洁,保持无明显异味,地面无明显积水。每日清洁一次、保洁两次;每周重点刷洗一次。重点区域的卫生间(如门诊等区域的公共卫生间),保洁巡视清洁频率应满足实际的质量标准要求。(项号 60)

3) 保持镜子洁净光亮,无明显污渍水迹,按规定频率刷洗清洁。每日清洁一次、保洁一次;每周重点刷洗一次。(项号 61)

4) 保持洗手盆内干净,按规定频率清洁。每日清洁一次;每周重点刷洗一次。(项号 62)

5) 保持排风口干净,无明显积尘。每周巡视清洁一次、每月专项清洁一次。(项号 63)

6) 保持淋浴区墙面干净,无皂渍、无明显污渍,按规定频率完成清洁。每日清洁一次;每周重点刷洗一次。(项号 64)

(4) 保洁设备

1) 保持清洁车及车上各种工具干净有序,无明显污渍,每日班前、班后整理、清洁一次。(项号 65)

2) 保持工作间干净整齐,每日整理、清洁一次。(项号 66)

3) 保持洗手盆和水池干净,无明显污渍。每日清洁一次、每周重点刷洗一次。(项号 67)

4) 保持员工的工作服干净、整洁。(项号 68)

(5) 走廊和楼梯(以下为班内时间保洁频率)

1) 保持走廊地面无明显黑色痕迹、无明显尘土、废弃物。每 90 分钟巡视、清扫一次,每日湿拖一次,每周刷洗边角一次,每月专项机器保养一次。(项号 69)

2) 保持墙角干净整洁,无明显污渍。每日尘推一次,每周重点刷洗一次。(项号 70)

3) 保持保持墙面干净,无明显污迹、污渍(已经渗透、损伤等除外)。每日清洁一次,每3个月全面清洁一次。(项号 71)

4) 保持电梯地面干净,无明显污渍、废弃物。每120分钟清扫一次,每日湿拖一次,刷洗边角日保每周重点一次;专项喷抛/洗地/每月一次。(项号 72)

5) 保持楼梯地面、台阶干净,无明显积尘、废弃物。每180分钟清扫一次,每日湿拖一次,每周重点刷洗边角一次。(项号 73)

(6) 办公室(以下为班内时间保洁频率)

1) 保持玻璃隔墙干净、无明显污渍手印。每日清洁(手可及处)一次;每2个月全面清洗一次。(项号 74)

2) 保持地面干净,无明显尘土、污渍、废弃物。每日湿拖一次。每120分钟清洁一次,每6个月机器刷洗一次。(项号 75)

3) 保持墙面干净,无明显污渍。每日清洁一次;每3个月重点清洁一次。(项号 76)

4) 将垃圾筐清倒干净。每日清洁一次,2周刷洗垃圾筐一次。(项号 77)

5) 保持公用房干净,无明显积尘、污渍。每日清洁一次,每2周重点清洁一次。(项号 78)

6) 保持办公家具、台面干净,无明显积尘、污渍。每日清洁一次,每2周重点清洁一次。(项号 79)

2、运送部服务质量标准:

(1) 标本运送:

▲1) 急标本:接到电话15分钟内到达需求科室;接到电话30分钟内送达相应的检验科室。

急标本的定义：血气、带冰标本、涉及抢救病人的所有标本。

2) 常规标本：早上 8-9 点第一趟用时为 1.5 小时以内，其他正常班内时间保持平均 40--60 分钟的循环频率（附各病区循环频率清单）。（项号 80）

3) 单据运送：1、急的退款单：接到电话 30 分钟内到达需求科室；接到电话 30 分钟内送达相应的科室。（项号 81）

4) 各类审批单、退款单：正常班内频率至少 2 次/上午，2 次/下午。（项号 82）

5) 各报告单：各功能科室工作时间内交付的报告单当天送达科室；各检查科室工作时间内交付的报告单当天送达科室。（项号 83）

6) 报纸、信件：收发室交付的报纸、信件当天送达（除需签收人员本人不在）。（项号 84）

7) 全院性文件发放：2 个工作日内。（项号 85）

（2）病人运送：

1) 预约病人：正常保持在预约时间前送达检查科室，但因为实际操作中存在“有时预约病人激增”现象，因此目标设定预约病人延迟不超过 30 分钟（非正常的病人原因、医护原因、多项检查、检查科室临时增加检查除外）。（项号 86）

2) 急送检查的病人：接到电话后 20 分钟内到达需求科室。（项号 87）

急送检查病人的定义：突发变症、需立即进行抢救的病人。（项号 88）

3) 入院病人运送：接到电话后 30 分钟到达需求科室。（抢救病人 15 分钟到达）（项号 89）

4) 病人出院：接到电话后 60 分钟内到达需求科室。（项号 90）

（3）仪器送修：

科室来电需要送修仪器，1 个工作日内送达维修处。急仪器送修 1 个小时内送达维修处。（项号 91）

（4）仪器运送：

1) 涉及抢救病人所需的仪器运送, 在接到电话并告之仪器明确存放地 20 分钟内到达仪器存放地。(项号 92)

2) 一个人可独立完成的物品运送(重量在 15 公斤内): 接到电话 60 分钟内到达需求科室。(抢救用的物品除外)(项号 93)

3) 需要两个人完成的物品、仪器运送(重量在 15 公斤以上): 接到电话 120 分钟内到达需求科室。(抢救用的物品除外)(项号 94)

4) 仪器运送之前运送员要检查仪器的外观是否正常, 如有裂痕、碰撞痕迹、线路脱落、车轮损坏等需及时与科室人员确认并汇报管理人员。较大型仪器比如运送胃镜、血细胞分离机、血透机、床边拍片机、床边心脏彩超机、体外循环机、大型呼吸机等要安排两名运送员一同运送, 运送前运送过程中两人要注意协作配合、步调一致, 途中注意观察路况、尽可能避开颠簸位置, 上下坡运送时尤其要注意稳定仪器重心。运送心电监护仪时配置提篮, 将仪器和附属线路装入提篮内运送。(项号 95)

(5) 更换氧气瓶运送:

常规更换氧气瓶, 接到电话后 5 小时内完成。(病区必须有备用氧气瓶)(项号 96)

(6) 行政仓库、器械仓库、外用药运送:

按照医院规定分区域、按时领用, 每周一次。(项号 97)

(7) 紫外线灯管擦拭: 每周一次。(项号 98)

(8) 消毒包的运送: 按照医院供应室要求的时间执行。(项号 99)

(9) 棉被翻晒: 2 次/年(按病区做出时间表)。(项号 100)

(10) 非驻守科室特别运送(工作任务涉及一次性需要 3 人含 3 人以上): 需提前与运送部预约。(项号 101)

(11) 病人满意率: 病人投诉经过证实员工确有过错(结果未引起医疗纠纷)每月不超过 3 次, 否则按规定进行处罚。(项号 102)

3、工程服务标准：（项号 103）

序号	工作类型	响应时间	完成时间	
			常规问题	特殊情况
1	市电停电	5 分钟	到达后 5 分钟	操作机构故障, 5 分钟后启动应急预案, 立即报总务科
2	火灾或者烟雾	5 分钟	即时办理至完成	立即报告保卫科
3	突发安全、灾害事件	5 分钟	即时办理至完成	立即报告总务科
4	电气焦味	5-8 分钟	即时办理至完成	立即报告总务科
5	局部断电	5-8 分钟	即时办理至完成	立即报告总务科
6	管道爆裂	5-8 分钟	即时办理至完成	立即报告总务科
7	漏电类	5-8 分钟	即时办理至完成	立即报告总务科
8	区域停水	10 分钟	即时办理至完成	立即报告总务科

9	人员被锁	10 分钟	到达后 10 分钟	立即报告总务科
10	电梯解困	5 分钟	即时办理至完成	立即报告总务科
11	插座无电(影响生命安全)	5 分钟	到达后 15 分钟	提供应急电源
12	马桶堵塞	30 分钟	到达后 10 分钟	2 个小时内将信息反馈用户
13	灯具不亮	2 小时	到达后 30 分钟	1 个工作日内信息反馈用户
14	插座无电（普通）	1-1.5 小时 (急需检查 30 分钟)	到达后 30 分钟	1 个工作日内信息反馈用户
16	局部管道无水	1 小时	到达后 2 小时	1 个工作日内信息反馈用户
17	下水道堵塞	班内 1 小时	到达后 2 小时	1 个工作日内信息反馈用户
18	管道滴漏	班内 2 小时	到达后 4 小时	1 个工作日内信息反馈用户
19	水龙头	班内 2 小时	到达后 30 分钟	1 个工作日内信息反馈用户

20	修门、窗、橱、柜类	班内 4 小时	到达后 3 小时	1 个工作日内信息 反馈用户
21	渗水处理	班内 4 小时 (影响治疗 1 小时)	到达后 4 小时	1 个工作日内信息 反馈用户
22	地面、墙壁、天花板的简单翻新及修补	班内 1 小时	到达后 4 小时	1 个工作日内信息 反馈用户
23	机房地面、管道、设备刷漆	班内 1 小时	到达后 4 小时	1 个工作日内信息 反馈用户

说明：上述服务标准为中标人到达、报修的工作标准。

（七）服务处罚标准

为满足医院日常工作正常运行的需要，现就中标人在工作中的服务质量制定以下标准，如果出现不符合质量标准的事件，如：运送延迟、保洁未按照规定的频率、工程维修响应时间延迟等，经查确属于中标人责任，根据事件的性质及造成的影响、损失等情况，医院有权对中标人处以 100 元-5000 元的扣款。（项号 104）

1、运送部

运送部按照如下规定的时间到达需求科室。如遇紧急运送，调度中心须跟进运送过程，当在规定时间前 3 分钟员工还没到达需求科室，调度中心必须了解员工目前状态并判断是否需要安排支持。（项号 105）

（1）标本运送：

1) 急标本：接到电话 15 分钟内到达需求科室；

如因运送部原因延迟 15-30 分钟到达，并造成投诉每次罚款 1000 元，延迟 30 分钟以上，将根据具体情节处以 2000-5000 元罚款。（项号 106）

2) 常规标本：早上 8-9 点第一趟用时为 1.5 小时以内，其他正常班内时间保持平均 40--60 分钟的循环频率。如因运送部原因延迟 30-60 分钟到达，每次罚款 300 元，延迟 60 分钟以上，将根据具体情节处以 500-2000 元罚款。（项号 107）

（2）病人运送：

1) 预约病人：在预约时间前送达检查科室（多项检查只能保证第一项检查按时送达）；如因运送部原因延迟 30-60 分钟送达，并造成投诉每次罚款 500 元，延迟 60 分钟以上，将根据具体情节处以 500-2000 元罚款。（项号 108）

2) 急送检查的病人：接到电话后 20 分钟内到达需求科室。如因运送部原因延迟 20-30 分钟到达，每次罚款 1000 元，延迟 30 分钟以上，将根据具体情节处以 1000-2000 元罚款。（项号 109）

3) 入院病人运送：接到电话后 30 分钟到达需求科室。如因运送部原因延迟 30-60 分钟到达，每次罚款 200 元，延迟 60 分钟以上，将根据具体情节处以 300-500 元罚款。（项号 110）

4) 病人出院：接到电话后 60 分钟内到达需求科室。如因运送部原因延迟 30-60 分钟到达，每次罚款 200 元，延迟 60 分钟以上，将根据具体情节处以 300-500 元罚款。（项号 111）

（3）仪器运送：

1) 抢救用设备在接到任务后 20 分钟内送达需求科室。如因运送部原因延迟 10-20 分钟到达，每次罚款 1000 元，延迟 20 分钟以上，罚款 2000 元。（项号 112）

2) 个人可独立完成的设备运送（重量在 15 公斤内）：在约定的时间 60 分钟内到达需求科室。如因运送部原因延迟 30-60 分钟到达，每次罚款 500 元，延迟 90 分钟以上，将根据具体情节给予 500-1000 元罚款。（项号 113）

3) 需要两个人完成的物品、仪器运送, 在约定的时间 120 分钟内到达需求科室。如因运送部原因延迟 60-90 分钟到达, 每次罚款 300 元, 延迟 120 分钟以上, 将根据具体情节给予 500-1000 元罚款。(项号 114)

4) 如果在仪器运送过程中因运送部原因造成仪器损坏, 将按照损失情况进行全额赔偿。(项号 115)

备注: 以上各项工作, 如因运送部原因(延时等情况)延误病情, 造成医疗纠纷等, 除罚款外, 中标人应承担相应的法律责任。

2、保洁部

(1) 入口和大厅(以下为班内时间保洁频率), 未按以下规定执行每次罚款 100 元, 对漏做的工作必须按规定的要求、频率补做, 并罚款 300 元或根据具体情况进行处罚。(项号 116)

1) 保持地面干净, 每 30 分钟巡视一次, 清扫地面烟头和废弃物; 每日一次湿拖地面; 每 3 天一次机器刷洗。(项号 117)

2) 每日一次清洁大厅入口处的玻璃, 去除玻璃上的手印; 每月一次专项全面清洗。(项号 118)

3) 保持脚垫干净整洁, 无明显沙土, 无明显废弃物。每周冲洗一次。(项号 119)

4) 及时清理烟灰缸内的烟头和杂物, 每日冲洗一次烟灰缸; 每周清洗一次烟灰桶内胆。(项号 120)

5) 及时清洁金属门和金属护板。每日一次全面擦拭污迹; 每月一次全面清洁抛光。(项号 121)

(2) 病房/护士站/公用设施房/其他房间(以下为班内时间保洁频率), 未按以下规定执行每次罚款 100 元, 对漏做的工作必须按规定的要求、频率补做, 并罚款 300 元或根据具体情况进行处罚。(项号 122)

1) 保持地面干净, 无明显积尘, 无明显废弃物, 开水间地面无明显积水。每 180 分钟巡视一次病房, 上午 9-11 点每小时巡视一次护理站; 每日一次地面湿拖; 每月一次地面专项保养。(项号 123)

2) 保持垃圾桶干净并套有干净的垃圾袋。每 240 分钟巡视病房垃圾桶一次; 每 180 分钟巡视附属房垃圾桶一次; 每日一次冲洗烟灰缸; 每周一次清洗烟灰桶内胆。(项号 124)

3) 保持墙面干净, 无明显污渍, 每日一次巡查、清洁; 每 3 个月一次全面清洁。(项号 125)

4) 保持窗户干净, 无明显污渍、手印, 门窗顶部无积尘。当班中, 每日一次巡查、清洁低处(手可及处); 每 2 个月一次全面专项清洁。(项号 126)

5) 保持家具干净, 无明显黑尘、污迹, 每日清洁一次。(项号 127)

(3) 卫生间(以下为班内时间保洁频率), 未按以下规定执行每次罚款 100 元, 对漏做的工作必须按规定的要求、频率补做, 并罚款 300 元或根据具体情况进行处罚。(项号 128)

1) 保持座便器干净, 无明显污渍。每日清洁一次; 每周重点刷洗一次。(项号 129)

2) 按规定频率完成卫生间刷洗清洁, 保持无明显异味, 地面无明显积水。每日清洁一次、保洁两次; 每周重点刷洗一次。(项号 130)

3) 保持镜子洁净光亮, 无明显污渍水迹, 按规定频率刷洗清洁。每日清洁一次、保洁一次; 每周重点刷洗一次。(项号 131)

4) 保持洗手盆内干净, 按规定频率清洁。每日清洁一次; 每周重点刷洗一次。(项号 132)

5) 保持排风口干净, 无明显积尘。每周巡视清洁一次、每月专项清洁一次。(项号 133)

6) 保持淋浴区墙面干净, 无皂渍、无明显污渍, 按规定频率完成清洁。每日清洁一次; 每周重点刷洗一次。(项号 134)

(4) 保洁设备, 未按以下规定执行每次罚款 100 元, 对漏做的工作必须按规定的要求、频率补做, 并罚款 300 元或根据具体情况进行处罚。(项号 135)

1) 保持清洁车及车上各种工具干净有序, 无明显污渍, 每日班前、班后整理、清洁一次。(项号 136)

2) 保持工作间干净整齐, 每日整理、清洁一次。(项号 137)

3) 保持洗手盆和水池干净, 无明显污渍。每日清洁一次、每周重点刷洗一次。(项号 138)

(5) 走廊和楼梯(以下为班内时间保洁频率), 未按以下规定执行每次罚款 100 元对漏做的工作必须按规定的要求、频率补做, 并罚款 300 元或根据具体情况进行处罚。(项号 139)

1) 保持走廊地面无明显黑色痕迹、无明显尘土、废弃物。每 90 分钟巡视、清扫一次, 每日湿拖一次, 每周刷洗边角一次, 每月专项机器保养一次。(项号 140)

2) 保持墙角干净整洁, 无明显污渍。每日尘推一次, 每周重点刷洗一次。(项号 141)

3) 保持保持墙面干净, 无明显污迹、污渍(已经渗透、损伤等除外)。每日清洁一次, 每 3 个月全面清洁一次。(项号 142)

4) 保持电梯地面干净, 无明显污渍、废弃物。每 120 分钟清扫一次, 每日湿拖一次, 刷洗边角日保每周重点一次; 专项喷抛/洗地/每月一次。(项号 143)

5) 保持楼梯地面、台阶干净, 无明显积尘、废弃物。每 180 分钟清扫一次, 每日湿拖一次, 每周重点刷洗边角一次。(项号 144)

(6) 办公室(以下为班内时间保洁频率), 未按以下规定执行每次罚款 100 元对漏做的工作必须按规定的要求、频率补做, 并罚款 300 元或根据具体情况进行处罚。(项号 145)

1) 保持玻璃隔墙干净、无明显污渍手印。每日清洁（手可及处）一次；每2个月全面清洗一次。（项号 146）

2) 保持地面干净，无明显尘土、污渍、废弃物。每日湿拖一次。每120分钟清洁一次，每6个月机器刷洗一次。（项号 147）

3) 保持墙面干净，无明显污渍。每日清洁一次；每3个月重点清洁一次。（项号 148）

4) 将垃圾筐清倒干净。每日清洁一次，2周刷洗垃圾筐一次。（项号 149）

5) 保持公用房干净，无明显积尘、污渍。每日清洁一次，每2周重点清洁一次。（项号 150）

6) 保持办公家具、台面干净，无明显积尘、污渍。每日清洁一次，每2周重点清洁一次。（项号 151）

备注：根据以上各项工作条例，设计工作验收表格并由管理人员检查填写（抽查），每周汇总上报总务处备案。

（八）人员薪酬待遇等要求

中标人自行负责其招聘员工的一切工资、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责；中标人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，并承担相应的费用。（项号 152）

1、员工的基本工资应不低于当地政府规定的最低工资标准。（项号 153）

2、全部服务人员应严格按照国家有关法律、法规要求的标准、基数和比例交纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤、生育险和住房公积金等福利。（项号 154）

3、全部服务人员的工作时间应严格按国家有关法律、法规要求的标准执行（每周工作时间不超40小时，因工作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按国家有关法律、法规要求的标准给付员工加班薪资。（项号 155）

4、全部服务人员劳动合同的执行严格按《中华人民共和国劳动合同法》之标准。
(项号 156)

5、所有员工入院服务时都必须经过体检，并且合格的才能上岗。(项号 157)

6、所有员工都要根据需求定期进行肝炎疫苗的注射、定期进行新型冠状病毒核酸检测。(项号 158)

7、投标人都要买公众责任险和员工的意外保险。(项号 159)

8、部门经理等管理人员应接受院方监督，中标人应承诺接受院方对其服务质量进行监督，并配合院方接受上级行政主管部门开展的各项检查评比工作。院方认为中标人的部门经理不称职时，中标人应无条件服从并更换。(项号 160)

(九) 其它要求

1、本招标文件中所发生的一切费用均应包含在投标报价中。(项号 161)

2、本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包、分包及挂靠，如有发现，采购人有权单方终止合同，且中标人必须赔偿由此给采购人带来的一切损失。(项号 162)

3、如因物业管理工作人员过错造成运送仪器损坏，一经查实，物业管理公司应赔偿院方损失。(项号 163)

4、医疗垃圾袋(黄色)、垃圾容器、锐器盒由医院提供，生活垃圾袋(黑色污物袋)由中标人提供；运送车辆、工具由医院提供；工程所需维修材料由医院提供，工具、仪器、设备由中标人提供。(项号 164)

5、物业公司每月要提供人员打卡考勤表报采购人人事科及总务科。(项号 165)

6、采购人有权对后期根据科室工作量的需求在总人数不变、服务费不变的情况下对物业人员进行优化。(小区域微调)(项号 166)

(十) 服务期：

合同生效后 2 年。(项号 167)

(十一) 中标价格执行及付款方式:

1、采购人向中标人支付的服务费，每月结算。中标人在每月 25 日将本月发票交付采购人，采购人在收到中标人的发票后 15 日内付款。（项号 168）

2、如果在合同期内，采购人在本章第（一）条“服务范围及岗位要求”内的区域、区域用途、设备或工作任务的总量出现增加、减少或变更的情况，经采购人和中标人协商后签订补充协议，对服务费金额作相应的增加或者减少，补充协议金额不超过本项目合同金额的 10%。（项号 169）

3、在合同期内，中标人应保障全部员工的合法权益。（项号 170）

第二部分 采购实施计划

三、制定采购实施计划

(一) 根据《需求管理办法》第二十八条确定编制单位

编制单位: 福建省智盛招标有限公司

编制时间: 2022 年 11 月 16 日

(二) 明确合同订立安排事项

1. 根据《需求管理办法》第十五条确定开展采购活动的时间: 2022 年 11 月中旬开展采购需求调查; 2022 年 11 月下旬完成招标文件编制工作, 发布预告, 招标文件评审工作; 2022 年 11 月下旬发布招标公告; 2022 年 12 月中旬开标评标、发布结果公告; 2022 年 12 月下旬签订合同事宜。

2. 根据《需求管理办法》第十六条确定采购组织形式和代理机构

(1) 采购组织形式:

☐ 集中采购

☒ 分散采购

☐ 自行采购

(2) 代理机构选择方式及结果 (根据项目特点、代理机构专业领域和综合信用评价结果确定):

☐ 自主选择: _____

☐ 全库摇号: _____

☒ 单位自建库摇号: _____

3. 采购项目项目预 (概) 算及最高限价

包 1 预 (概) 算: 23930000 元

最高限价: 23930000 元

4. 根据《需求管理办法》第十九条确定采购方式并说明理由。

(1) 采购方式

☒ 公开招标

☐ 邀请招标

☐ 竞争性谈判

☐竞争性磋商

☐询价

☐单一来源采购

☐其他采购方式：_____

选择采购方式的理由：采购需求客观、明确且规格、标准统一的采购项目

(2) 采购方式是否需要财政部门批准：

☒不需要

☐需要，报批安排：_____

5. 根据《需求管理办法》第二十条明确项目竞争范围

☒公开方式

☐邀请方式，依据：_____

6. 根据《需求管理办法》第十七条明确采购包或合同分包要求：

包号	标的名称	品目 分类编码	计量 单位	数量	是否 进口	分包 要求
包 1	物业管理服务	C1204	批	1	否	不允许中标（成交）供应商将本项目的非主体、非关键性工作分包

采购进口清单外的产品报财政部门核准安排：无

7. 根据《需求管理办法》第十四条、第十八条设定供应商资格条件

包 1

无。

8. 根据《需求管理办法》第十九条、第二十一条确定评审方法和评审因素

包 1

☐最低评标价法，选择该评审规则的理由：_____

☒综合评分法，选择该评审规则的理由：不能完全确定客观指标，需由供应商提

供设计方案、解决方案或者组织方案，已结合需求调查的情况，尽可能明确不同技术路线、组织形式及相关指标的重要性和优先级，设定客观、量化的评审因素、分值和权重。

评审项目	评审分值	评审方法描述
价格项	15	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。
	价格扣除的规则	1、经采购人确认本项目为非专门面向中小企业项目，评审时，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业，将依据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（闽财规〔2022〕13号）对其报价给予15%价格扣除，用扣除后的价格参加评审。供应商须提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业声明函（格式详见采购文件），否则不予价格扣除。2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。3、根据财政部、民政部、中国残联文件（财库〔2017〕141号）及福建省财政、福建省民政厅、福建省残疾人联合会联合发布的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业

		政策的通知》、福建省财政《关于残疾人福利性单位参加政府 采购活动价格扣除的通知》，凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，但必须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见采购文件），对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。4、供应商应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字（2017）213号）规定准确划分企业类型。若招标文件中的有关条款与本条款有矛盾之处以此处为准。5、具体详见招标文件第三章、第七章规定，上述规定与政府采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。注：享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
技术项（F2×A2）满分为 60 分		
评标项目	评标分值	评标方法描述
F2.1 服务内容响应	27.4	根据各投标人对招标文件第五章招标内容及要求的逐项应答情况并结合相关佐证材料（若有）由评委进行评议并评分，完全响应招标文件的得 27.4 分，带★号条款有任何一项负偏离即为无效投标，带▲号条款（共 7 项）每负偏离一项扣 1 分，未带

		符号的条款（共 170 项）每负偏离一项扣 0.12 分，正偏离不加分。投标响应的偏离情况须在《技术和服务要求响应表》中逐一对应列明，否则视为无效投标。
F2.2 实施服务方案	2.6	根据投标人针对本项目提供的项目整体方案（至少应包含管理运作流程、管理方案、总体组织实施服务方案），由评委进行评议并打分：①方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、内容详实、各要点内容之间关联性强，逻辑清晰，可操作性强的得 2.6 分；②方案部分详实或部分内容可操作性较强的得 2 分；③方案所包含的要点缺项，内容简略，可操作性不明显的得 1 分，④方案存在明显缺项、不可行的或未提供的本项不得分。（满分 2.6 分）
F2.3 项目经理	3	为了确保项目服务质量，根据投标人针对本项目拟投入的项目经理（管理负责人）应具备拟任工作所必备的文化知识和工作能力，投标人同时提供本项序号 1-4 序号证明材料的得 3 分：①具有本科（含）及以上学历（须提供有效学历证书复印件）；②年龄不大于 50 岁，具备物业管理行业从业人员岗位证书，（须提供有效岗位证书复印件）；③在二甲及以上医院服务 3 年及以上（服务内容中包须含有保洁服务、运送服务、后勤工程维修服务）工作经验；④提供以往至少一年及以上作为项目经理（管理负责人）服务过的医院出具的相关工作经验证明材料复印件，同时投标人还应提供本项目投标截止时间前连续 6 个月（不含投标截止当月）投标人为其缴纳社保的证明材料复印件及其身份证复印件，否则本评分项均不得分。（满分 3 分）。
F2.4 设备设施配置的情况	3	根据投标人针对本项目投入设备设施配置的情况以及是否切合医院物业管理的实际情况进行评议，主要从投入本项目的设备设施配置（必须提供设备的技术参数、名称、件数等文件）的专业、完善等方面进行分析，由评委进行评议并打分：①专业、

		完善的得 3 分；②较专业、较完善的得 2 分；③一般的得 1 分。需提供投标人公司或其分公司购置设备的发票；④方案存在明显缺项、不可行的或未提供的本项不得分。（满分 3 分）
F2.5 应急方案	3	根据投标人针对本项目提供的应急方案（至少应包含对医院的突发事件、遇自然灾害等方面）的情况，由评委进行评议并打分：①方案详实、可操作性强的得 3 分；②方案部分详实或部分内容可操作性较强的得 2 分；③方案阐述简短或可操作性不强的得 1 分；④方案存在明显缺项、不可行的或未提供的本项不得分。（满分 3 分）
F2.6 院感控制方案	3	根据投标人针对本项目提供的院感控制方案（至少应包含防止交叉感染、消毒隔离措施等医院感染控制措施方面），由评委进行评议并打分：①方案整体思路清晰，内容描述准确，设计合理，结构清晰、有对从业人员进行医院感染规范的培训师资力量（须提供培训师为主讲人的医疗机构相关医院感染培训的相关材料并加盖公章），逻辑性强的得 3 分；②方案整体思路较为清晰，内容描述较为准确，设计合理性较好的得 2 分；③内容描述模糊，内容描述简单，设计不够合理，结构简单、逻辑性一般的得 1 分；④方案存在明显缺项、不可行的或未提供的本项不得分。
F2.7 质量控制方案	3	根据投标人针对本项目提供的质量控制方案（至少应包含质量目标计划、质量控制计划、质量保证计划及改进计划等方面）由评委进行评议并打分：①方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、内容详实、各要点内容之间关联性强，逻辑清晰，可操作性强的得 3 分；②方案部分详实或部分内容可操作性较强的得 2 分；③方案所包含的要点缺项，内容简略，可操作性不明显的得 1 分；④方案存在明显缺项、不可行的或未提供的本项不得分。（满分 3 分）

F2.8 医疗废弃物， 垃圾分类收集 方案	3	根据投标人针对本项目提供的医疗废弃物、生活垃圾的分类收集方案（至少应包含收集分类、暂存、转送等方面），由评委进行评议并打分：①方案整体思路清晰，内容描述准确，设计合理，结构清晰、逻辑性强的得3分；②方案整体思路较为清晰，内容描述较为准确，设计合理性较好的得2分；③内容描述模糊，内容描述简单，设计不够合理，结构简单、逻辑性一般的得1分；④方案存在明显缺项、不可行的或未提供的本项不得分。（满分3分）
F2.9 疫情防控管理	3	根据投标人针对本项目提供的针对新冠肺炎疫情等重大传染性疾病所采用的防控工作方案（至少应包含①对在岗人员、新聘人员的排查或健康检测措施，②防控物资投入，③业务往来人员的防控措施），由评委进行评议并打分：①详实、可操作性强的得3分；②方案部分详实或部分内容可操作性较强的得2分；③方案阐述简短或可操作性不强的得1分；④方案存在明显缺项、不可行的或未提供的本项不得分。（满分3分）
F2.10 物业管理 制度	3	根据投标人针对本项目提供的物业管理制度（至少应包含保洁、运送、机电设备运行与维护、电梯运行与维护管理制度及奖惩措施等方面）情况，由评委进行评议并打分：①方案整体思路清晰，内容描述准确，设计合理，结构清晰、逻辑性强的得3分；②方案整体思路较为清晰，内容描述较为准确，设计合理性较好的得2分；③内容描述模糊，内容描述简单，设计不够合理，结构简单、逻辑性一般的得1分；④方案存在明显缺项、不可行的或未提供的本项不得分。
F2.11 物业交 接过渡 工作方	3	根据投标人针对本项目提供的交接过渡工作方案（至少应包括进场前期介入方案、交接工作计划、物质装备配备计划、档案交接，进场和退场交接方案），由评委进行评议并打分：①详实、可操作性强的得3分；②方案部分详实或部分内容可操作

案		性较强的得 2 分； ③方案阐述简短或可操作性不强的得 1 分； ④方案存在明显缺项、不可行的或未提供的本项不得分。(满分 3 分)
F2.12 物业后勤服务 档案管理	3	根据投标人提供针对本项目的物业后勤服务档案管理（至少应包含保洁服务管理档、日常管理档案、使用设备档案、财务档案以及其他档案的建立及管理方案），从后勤服务档案管理方案的可行性、合理性、完整性等，由评委进行评议并打分：①详实、可操作性强的得 3 分；②方案部分详实或部分内容可操作性较强的得 2 分；③方案阐述简短或可操作性不强的得 1 分；④方案存在明显缺项、不可行的或未提供的本项不得分。(满分 3 分)
商务项 (F3×A3) 满分为 25 分		
评标项目	评标分值	评标方法描述
F3.1 企业综合实力	3	1、投标人通过 ISO 质量管理体系认证并在认证有效期限内的得 1 分。2、投标人通过 ISO 环境管理体系认证并在认证有效期限内的得 1 分。3、投标人通过 ISO 职业健康安全管理体系认证并在认证有效期限内的得 1 分。注：须提供相关有效期限内的认证证书复印件和中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)或中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn)网站的下载网页（或截图），否则该项不得分。投标人提供的证书中信息与网页信息不一致的不得分。(满分 3 分)

F3.2 企业专业认证	1	投标人获得 SA8000 标准的企业社会责任管理体系信息安全管理体 证证书并在有效期内的，得 1 分。注：投标人须提供相关有效其 的认证证书复印件和中国国家认证认可监督管理委员会 (http://www.cnca.gov.cn) 或中国合格评定国家认可委员会 (https://www.cnas.org.cn) 网站的下载网页（或截图），否则该项不得 投标人提供的证书中信息与网页信息不一致的不得分。（满分 1
F3.3 企业强化培训管理情况	3	为了确保项目服务品质，强化员工的长期有效培训，进行培训 学习时长量化管理。根据投标人提供近三年在二甲及以上医院 物业服务项目中，对该项目员工培训有效学习时长情况进行评 分：①项目所有岗位人员平均每人学习时长≥ 50 小时/年的得 1 分；②项目所有岗位人员平均每人学习时长≥ 80 小时/年的得 2 分；③项目所有岗位人员平均每人学习时长≥ 100 小时/年的得 3 分。（注：投标人须提供有人脸识别学习鉴别功能的网络学 习平台体现学习时长的网页截图，也可提供投标人公司现场学 习照片或视频体现学习时长的截图。须提供项目中标（成交） 通知书复印件，项目采购合同文本关于岗位人员人数关键页复 印件，及该项目岗位员工在培训学习期间的任一个月投标人为 其缴纳的社保证明材料，须提供该项目员工学习签到表与考核 表，及员工学习培训内容，未提供的本项不得分）。（满分 3 分）
F3.4 企业业绩	3	根据投标人提供的自 2019 年 1 月 1 日以来至截至投标截止时间 止（以验收合格时间为准）已完成为二甲及以上医院物业服务 项目（服务内容中须至少包含本项目招标服务的 2 项内容）进 行评价。每提供一个有效业绩的，得 0.5 分，满分 3 分。每项业 绩均须提供以下证明材料：1、中标(成交)公告(提供相关网站 中标(成交)公告的下载网页及其网址)；2、中标(成交)通知书 复印件；3、采购合同文本关键页复印件(合同材料中须体现其

		所包含的服务内容); 4、验收合格证明材料复印件。注: 本评分项与商务评分项 F3.5 项、F3.6 项所涉及的项目不得重复, 否则该项目均不得分。同一采购人的多个不同合同文本只计一个项目, 不得累加计分。(满分 3 分)
F3.5 企业在 管项目	3	根据投标人提供的截至投标当日仍在履约的为二甲及以上医院提供物业服务项目(服务内容中须至少包含本项目招标服务的 2 项内容) 情况进行评价。每提供 1 个得 0.5 分, 满分 3 分。每个项目有效证明材料须同时包括: 1、中标(成交) 公告(提供相关网站中标(成交) 公告的下载网页及其网址); 2、中标(成交) 通知书复印件; 3、采购合同文本关键页复印件(合同材料中须体现其所包含的服务内容以及合同履约期要体现涵盖投标截止时间)。注: 正在履约项目在本评分项才可计分。本评分项与商务评分项 F3.4 项、F3.6 项所涉及的项目不得重复, 否则该项目均不得分。同一采购人的多个不同合同文本只计一个项目, 不得累加计分。(满分 3 分)
F3.6 企业满 意度	3	根据投标人提供承接的为二甲及以上医院提供物业服务项目(服务内容中须至少包含本项目招标服务的 2 项内容) 的服务满意度评价情况进行评价, 服务满意度评价意见为优秀或满意, 每提供 1 个得 0.5 分, 满分 3 分。有效证明材料须同时包括: 1、中标(成交) 公告(提供相关网站中标(成交) 公告的下载网页及其网址); 2、中标(成交) 通知书复印件; 3、采购合同文本关键页复印件(合同中须体现其所包含的服务内容及签订时间); 4. 能够证明该业绩已经采购人满意度考核优秀或满意的相关证明材料。注: 已完成项目和正在履约项目在本评分项均可计分。本评分项与商务评分项 F3.4 项、F3.5 项所涉及的项目不得重复, 否则该项目均不得分。同一采购人的多个不同合同文本只计一个项目, 不得累加计分。(满分 3 分)

F3.7 企业抗 风险能 力	3	根据投标人承诺中标后为本项目投入的所有人员（每人）购买意外伤害保险或雇主责任险的保额情况进行评分，保额 ≥ 100 万元/人的得3分；100万元/人 $>$ 保额 ≥ 70 万元/人的得2分；70万元/人 $>$ 保额 ≥ 40 万元/人的得1分，保额 < 40 万元/人的不得分。需提供承诺函且承诺为本项目投入的所有人员购买的意外伤害险的保障日期不少于本项目合同服务期，未提供的不得分。（满分3分）
F3.8 企业信 息化能 力	3	F3.8.1 针对能提升本项目信息化管理能力和水平的软件著作权：①支持物业运送服务管理与临床及医技相关联的信息管理系统；②支持环境保洁服务信息管理系统；③支持后勤设施、设备运行与维护管理信息系统。投标人每提供其中1项信息软件并承诺中标后应用于本项目得1分，满分3分。注：①软件著作权为投标人自有的，须提供软件著作权登记证书（登记人为投标人）和中标后应用于本项目的承诺函。②软件为外购的，须提供购买合同（出售方须为原始软件著作权登记人）、正式发票（开票单位须为原始软件著作权登记人）、原始软件著作权登记证书（登记人须与上述合同中出售方及出售发票开票人一致）和中标后用于本项目的承诺函。否则不得分。（满分3分）
	2	F3.8.2 针对能提升本项目信息化管理能力和水平的软件著作权：①支持医疗废弃物、生活垃圾分类信息管理系统；②支持医院智慧后勤一体化运维信息管理系统。投标人每提供其中1项信息软件并承诺中标后应用于本项目得1分，满分2分。注：①软件著作权为投标人自有的，须提供软件著作权登记证书（登记人为投标人）和中标后应用于本项目的承诺函。②软件为外购的，须提供购买合同（出售方须为原始软件著作权登记人）、正式发票（开票单位须为原始软件著作权登记人）、原始软件著作权登记证书（登记人须与上述合同中出售方及出售发票开票人

		一致)和中标后用于本项目的承诺函。否则不得分。(满分 2 分)
F3.9 企业信 息化支 持案例	1	投标人拟投入本项目的后勤信息化管理软件(①物业运送服务管理与临床及医技相关联的信息管理系统; ②环境保洁服务信息管理系统; ③后勤设施、设备运行与维护管理信息系统; ④医疗废弃物、生活垃圾分类信息管理系统, ⑤医院智慧后勤一体化运维信息管理系统), 每提供一个具备二甲及以上医院服务项目 (含仍在履约服务中的项目) 应用案例得 0.5 分, 满分 1 分; 投标人须提供相关信息软件应用案例的业主加盖公章的证明材料及服务合同复印件, 未提供的不得分。(满分 1 分)

(三) 合同管理安排

1. 根据《需求管理办法》第二十二条确定合同类型

包 1

☐ 买卖合同

☐ 建设工程合同

☐ 技术合同

☒ 物业服务合同

☐ 委托合同

☐ 其他: _____

选择合同类型的理由: 投标人应以包括完成本项目所涉及的有关项目的所有费用进行报价, 包括但不限于: 基础设施和设备配备、项目工作人员 (人员工资、福利待遇、劳保培训、项目管理等费用)、税收等一切相关费用。

2. 根据《需求管理办法》第十九条确定定价方式并说明理由

包 1

☒ 固定总价

☐ 固定单价

☐ 成本补偿

☐ 绩效激励

选择定价方式的理由: 采购需求客观、明确且规格、标准统一的采购项目

3. 根据《需求管理办法》第二十三条确定合同文本的主要条款

☒属于《需求管理办法》第十一条范围的采购项目，合同文本需经法律顾问审定。

☐不需要

包 1

本项目为 1000 万元以上的服务采购项目。

4. 根据《需求管理办法》第二十四条制定履约验收方案

包 1

(1) 履约验收主体

☒采购人：_____

☐采购代理机构：_____

☐本项目的其他供应商：_____

☐第三方专业机构：_____

☒专家：_____

☐服务对象：_____

☐其他：_____

(2) 履约验收时间

服务期结束后。

(3) 履约验收方式

采购人邀请专家根据招标文件、投标文件、以及采购合同要求情况进行验收。

(4) 履约验收程序

本项目服务期结束后，采购人、采购代理机构将邀请专家根据招标文件、投标文件、以及采购合同要求情况进行验收，验收标准包括所有客观、量化指标，相关验收意见作为验收的参考资料。

(5) 履约验收内容

招标文件、投标文件、以及采购合同中的内容。

(6) 履约验收验收标准

包括所有客观、量化指标，相关验收意见作为验收的参考资料

(7) 履约验收其他事项

无。

5. 根据《需求管理办法》第二十五条制定风险管控措施

包 1

(1) 国家政策变化应对措施: 采购阶段: 按新政策调整; 合同签订: 终止合同的签订; 履约阶段: 终止合同。因国家政策变化属于不可抗力, 双方不承担不签订合同或不履约的法律责任。

(2) 实施环境变化应对措施: 可预见的: 调整采购需求; 不可预见的: 双方协商调整采购需求, 若因不可抗力不能履行民事义务的, 不承担民事责任。

(3) 重大技术变化应对措施: 采购公告环节: 根据是否影响预算进行更正或重新开展采购活动 (原预算金额过高: 更正公告、设置最高限价; 原预算金额过低: 终止采购, 报告本级财政部门, 调整预算重新组织采购活动); 采购过程: 终止采购活动; 采购结果环节: 废标 (将废标理由通知所有投标人, 且将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。除采购任务取消情形外, 须重新组织招标。需要采取其他方式采购的, 应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准); 合同履行过程: 终止采购合同。

(4) 预算项目调整应对措施: 预算主管部门审批; 同项目预算调剂: 同级财政部门审批。

(5) 因质疑投诉影响采购进度应对措施: 妥善处理质疑: 组织专家重新评审、组织原评标委员会协助质疑答复等, 配合处理投诉。

(6) 采购失败应对措施: 重新组织采购或变更采购方式。

(7) 不按规定签订或者履行合同应对措施: 供应商拒签合同的: 类推下一候选人 (若有) 或重新开展采购活动; 并报告财政部门。供应商不按规定履行合同 (擅自变更、中止、终止合同) 的: 改正后继续履约, 按照合同约定追究供应商的违约责任; 情节严重或者拒不整改的追究民事责任 (包括赔偿及履约保证金等), 同时报财政部门, 由财政部门依法处理。

(8) 出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施:

1、调查阶段: 调整需求内容; 2、采购文件编制阶段: 采购文件调整; 3、评审过程: 终止评审; 4、合同签订: 终止合同的签订, 向财政部门备案; 5、履约阶段:

双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第三部分 审查意见

四、采购需求和采购实施计划的审查意见

(一) 审查时间及地点:

审查时间: 2022年12月1日下午17:00(北京时间)

审查地点: 福建省平潭县北厝镇临湖7路2号

(二) 审查对象

1. 采购需求

(1) 参与确定采购需求的专家、第三方机构:

参与确定采购需求的专家: 郭培红、林金雄、张玉兰、陈文钦、何新辉、第三方机构: 福建省智盛招标有限公司

(2) 采购需求版次: 2022年11月9日发布的采购需求调查的征求公告内容

2. 采购实施计划

(1) 参与确定采购实施计划的专家、第三方机构:

参与确定采购需求的专家: 郭培红、林金雄、张玉兰、陈文钦、何新辉、第三方机构: 福建省智盛招标有限公司

(2) 采购实施计划版次: 2022年11月9日发布的采购需求调查的征求公告内容

(三) 根据《需求管理办法》第三十二条确定审查人员

序号	姓名	单位	内部机构	职务/职称	联系方式	备注
1	陈春美	平潭综合实验区医院	院部	院长	23166603	
2	陈芳	平潭综合实验区医院	院部	党总支书记	23166667	
3	李平	平潭综合实验区医院	院部	副院长	23166606	
4	潘杰	平潭综合实验区医院	院部	副院长	23166605	
5	翁平平	平潭综合实验区医院	院部	副院长	23166668	
6	林在香	平潭综合实验区医院	院部	副院长	23166669	
7	俞兆宏	平潭综合实验区医院	院部	副院长	23166687	

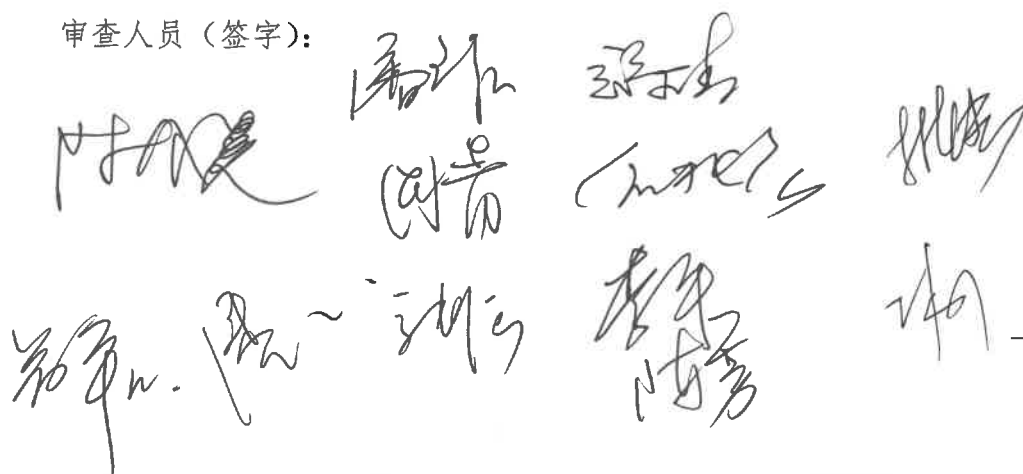
8	周青	平潭综合实验区医院	院部	副院长	23166689	
9	潘耀	平潭综合实验区医院	党办	副主任	13799943855	
10	念保清	平潭综合实验区医院	审计科	副科长	13960893529	
11	张强	平潭综合实验区医院	财务科	科长	13809529756	
12	林升	平潭综合实验区医院	总务科	临时负责人	18759129592	

(四) 审查内容与结果

1. 根据《需求管理办法》第三十条开展一般性审查

审 查 内 容	审查结果	审查不通过原因
如需开展需求调查的,是否按规定开展需求调查	是	无
采购需求是否符合预算管理制度规定	是	无
采购需求是否符合资产管理制度规定	是	无
采购需求是否符合财务管理制度规定	是	无
对采购方式的选择是否说明适用理由	是	无
对评审规则的选择是否说明适用理由	是	无
对采购合同类型的选择是否说明适用理由	是	无
对定价方式的选择是否说明适用理由	是	无
属于按规定需要报相关监管部门批准、核准的事项,是否作出相关安排	是	无
采购实施计划是否完整	是	无
审查结论	通过	

审查人员(签字):



2. 重点审查

(1) 根据《需求管理办法》第三十三条确定是否需要重点审查

☒需要，属于《需求管理办法》第十一条规定范围的项目

☐需要，主管预算单位或采购人确定的其他需要重点审查的项目

☐不需要

(2) 根据《需求管理办法》第三十一条开展重点审查

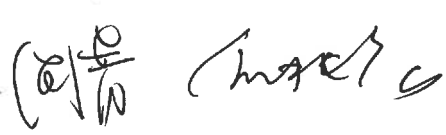
审 查 内 容		审查结果	审查不通过原因
非歧视性 审查（主要 审查是否 指向特定 供应商或 者特定产 品）	资格条件设置是否合理	是	无
	要求供应商提供超过 2 个同类业务合同的，是否具有合理性	否	无
	技术要求是否指向特定的专利、商标、品牌、技术路线等	否	无
	评审因素设置是否具有倾向性	否	无
	将有关履约能力作为评审因素是否适当	是	无
竞争性审 查（主要审 查是否确 保充分竞 争）	应当以公开方式邀请供应商的，是否依法采用公开竞争方式	是	无
	采用单一来源采购方式的，是否符合法定情形	本项目未采用单一来源采购	
	采购需求的内容是否完整、明确	是	无
	采购需求的内容是否考虑后续采购竞争性	是	无
	评审方法、评审因素、价格权重等评审规则是否适当	是	无
采购政策 审查	进口产品的采购是否必要	本项目未采购进口产品	
	是否落实支持创新政府采购政策要求	是	无
	是否落实绿色发展、节能环保政府采购政策要求	是	无

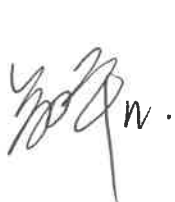
	是否落实中小企业发展政府采购政策要求	是	无
	是否落实支持监狱发展政府采购政策要求	是	无
	是否落实促进残疾人就业政府采购政策要求	是	无
履约风险审查	合同文本是否按规定由法律顾问审定	本项目为电子标，使用福建省政府采购公开信息系统的统一合同文本	
	合同文本运用是否适当	无	
	是否围绕采购需求和合同履行设置权利义务	无	
	是否明确知识产权等方面的要求	无	
	履约验收方案是否完整、标准是否明确	无	
	风险处置措施和替代方案是否可行	无	
采购人或者主管预算单位认为应当审查的其他内容	(应列明审查的具体内容)	无	
审查结论		通过	

审查人员（签字）：












（五）审查结论

审查结果全部为“通过”的，则审查结论为“通过”。审查结果有一项为“不通过”的，则审查结论为“不通过”。对于审查不通过的，应当修改采购需求和采购实施计划的内容并重新进行审查。

☒通过

☐不通过，应当修改并重新审查。

